ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

Libro Gordo

RESPIRATORIO

90 preguntas de práctica

Neumología Clínica

MATRIZ PERFIL V3 · DISTRIBUCIÓN POR BLOQUES

Respiratorio · Secuencia Cardinal de Estudio (Bloque 1 a 5)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
BLOQUE 1: VÍA AÉREA OBSTRUCTIVA Y FUNCIÓN PULMONAR					
1.05.1.002	Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q11	Tomo 04 · 1.3 (Pág. 11)
1.05.1.003	Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q12	Tomo 04 · 1.3 (Pág. 11)
1.05.1.005	Exacerbación Aguda de EPOC (Anthonisen)	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q17	Tomo 07 · 1.1 (Pág. 5)
1.05.1.006	Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q13	Tomo 04 · C.6 (Pág. 16)
1.05.1.009	Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q3	Tomo 04 · C.9 (Pág. 22)
1.05.1.016	Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) Estable	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q15	Tomo 04 · 1.4 (Pág. 13)
1.05.1.017	Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) Estable	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q16	Tomo 04 · 1.4 (Pág. 13)
1.05.1.020	Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q4	Tomo 04 · C.20 (Pág. 44)
1.05.1.021	Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q5	Tomo 04 · C.21 (Pág. 46)
1.05.1.035	Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q14	Tomo 04 · Respiratorio (Pág. 8)
1.05.2.002	Aspiración de cuerpo extraño con asfixia	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q1	Tomo 04 · Respiratorio (Pág. 8)
1.05.2.003	Aspiración de cuerpo extraño sin asfixia	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q2	Tomo 07 · 1.3 (Pág. 11)
1.05.2.004	Crisis Asmática en el Adulto	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q8, Q9, Q10	Tomo 04 · 1.2 (Pág. 7)
1.05.2.006	Exacerbación Aguda de EPOC (Anthonisen)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q18	Tomo 04 · 1.5 (Pág. 15)
1.05.4.001	Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q6, Q7	Tomo 04 · 1.1 (Pág. 5)
BLOQUE 2: INFECCIONES RESPIRATORIAS BAJAS Y SUPURACIONES					
1.05.1.001	Absceso Pulmonar y Supuraciones Pleuropulmonares	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q31, Q32, Q33	Tomo 04 · 2.4 (Pág. 30)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.05.1.008	Absceso Pulmonar y Supuraciones Pleuropulmonares	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q32, Q33, Q34	Tomo 04 · 2.4 (Pág. 30)
1.05.1.022	Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Diagnóstico y Severidad CURB-65	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q19	Tomo 04 · C.22 (Pág. 48)
1.05.1.027	Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Diagnóstico y Severidad CURB-65	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q20, Q21, Q22, Q23, Q24	Tomo 04 · 2.1 (Pág. 22)
1.05.1.028	Tratamiento Antimicrobiano de la NAC y Criterios GES	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q25, Q26	Tomo 04 · 2.2 (Pág. 26)
1.05.1.029	Neumonías Atípicas, Intrahospitalarias y Neumonía Aspirativa	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q27, Q28, Q29	Tomo 04 · 2.3 (Pág. 28)
1.05.1.030	Neumonías Atípicas, Intrahospitalarias y Neumonía Aspirativa	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q28, Q29, Q30	Tomo 04 · 2.3 (Pág. 28)
1.05.1.036	Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q35	Tomo 04 · Respiratorio (Pág. 8)
1.05.1.037	Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q36	Tomo 04 · 2.5 (Pág. 32)
BLOQUE 3: PATOLOGÍA PLEURAL Y URGENCIAS TORÁCICAS					
1.05.1.010	Derrame Pleural: Diagnóstico Diferencial y Criterios de Light	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q38, Q39, Q40	Tomo 04 · 3.1 (Pág. 39)
1.05.1.011	Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q41, Q42, Q43, Q44, Q45	Tomo 04 · 3.2 (Pág. 41)
1.05.1.012	Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q42, Q43, Q44, Q45, Q46	Tomo 04 · 3.2 (Pág. 41)
1.05.1.013	Derrame Pleural Neoplásico y Pleuritis Tuberculosa	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q54	Tomo 04 · 3.5 (Pág. 51)
1.05.1.031	Neumotórax Espontáneo Primario y Secundario	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q47, Q48, Q49	Tomo 04 · 3.3 (Pág. 45)
1.05.1.032	Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q50, Q51	Tomo 04 · 3.4 (Pág. 47)
1.05.2.011	Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Inicial**	GES	Q51, Q52	Tomo 04 · 3.4 (Pág. 47)
1.05.2.013	Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Inicial**	GES	Q51, Q53	Tomo 04 · 3.4 (Pág. 47)
1.05.2.014	Traumatismo torácico simple	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q37	Tomo 04 · Respiratorio (Pág. 8)
BLOQUE 4: ONCOLOGÍA PULMONAR, INTERSTICIO Y VASCULAR					
1.05.1.004	Hemoptisis y Bronquiectasias	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q70	Tomo 04 · 4.5 (Pág. 66)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.05.1.007	Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q58, Q59, Q60	Tomo 04 · 4.2 (Pág. 58)
1.05.1.008	Nódulo Pulmonar Solitario (NPS): Evaluación y Algoritmo Fleischner	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q56, Q57	Tomo 04 · 2.4 (Pág. 30)
1.05.1.015	Tromboembolismo Pulmonar (TEP) Agudo: Wells, Ginebra y Estratificación	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q67, Q68	Tomo 04 · 4.4 (Pág. 62)
1.05.1.018	Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas (EPID) y Fibrosis Pulmonar Idiopática	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q63, Q64, Q65	Tomo 04 · 4.3 (Pág. 60)
1.05.1.019	Hemoptisis y Bronquiectasias	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q71	Tomo 04 · 4.5 (Pág. 66)
1.05.1.025	Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q59, Q60, Q61	Tomo 04 · 4.2 (Pág. 58)
1.05.1.026	Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas (EPID) y Fibrosis Pulmonar Idiopática	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q64, Q65, Q66	Tomo 04 · 4.3 (Pág. 60)
1.05.1.034	Síndromes mediastínicos	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q55	Tomo 04 · Respiratorio (Pág. 8)
1.05.1.038	Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q59, Q60, Q62	Tomo 04 · 4.2 (Pág. 58)
1.05.2.005	Tromboembolismo Pulmonar (TEP) Agudo: Wells, Ginebra y Estratificación	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q68, Q69	Tomo 01 · 5.9 (Pág. 105)
1.05.2.007	Hemoptisis y Bronquiectasias	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q72	Tomo 04 · 4.5 (Pág. 66)
1.05.5.005	Nódulo Pulmonar Solitario (NPS): Evaluación y Algoritmo Fleischner	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q56, Q57	Tomo 04 · 4.1 (Pág. 56)
BLOQUE 5: CUIDADOS CRÍTICOS, VENTILACIÓN Y MEDICINA DEL SUEÑO					
1.05.1.014	Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA): Criterios de Berlín	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q82, Q83	Tomo 04 · 5.2 (Pág. 75)
1.05.1.023	Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica)	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q75, Q76, Q77, Q78, Q79	Tomo 04 · 5.1 (Pág. 71)
1.05.1.024	Intoxicación por Monóxido de Carbono e Inhalación de Humo	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Inicial**	GES	Q87, Q88, Q89	Tomo 04 · 5.4 (Pág. 79)
1.05.1.033	Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS)	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q84, Q85, Q86	Tomo 04 · 5.3 (Pág. 77)
1.05.2.001	Asfixia por inmersión	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q73	Tomo 04 · 5.5 (Pág. 81)
1.05.2.008	Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica)	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q76, Q77, Q78, Q79, Q80	Tomo 04 · 5.1 (Pág. 71)
1.05.2.009	Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica)	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q76, Q77, Q78, Q79, Q81	Tomo 04 · 5.1 (Pág. 71)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.05.2.010	**Intoxicación por Monóxido de Carbono e Inhalación de Humo**	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Inicial**	GES	Q88, Q89, Q90	Tomo 04 · 5.4 (Pág. 79)
1.05.2.012	**Paro cardiorespiratorio**	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q74	Tomo 01 · 1.2 (Pág. 7)

ÍNDICE CORRELATIVO OFICIAL PERFIL V3

Respiratorio · Códigos en Orden Numérico Correlativo Estricto (Sin Bloques)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.05.1.001	Absceso Pulmonar y Supuraciones Pleuropulmonares	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q31, Q32, Q33	Tomo 04 · 2.4 (Pág. 30)
1.05.1.002	Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q11	Tomo 04 · 1.3 (Pág. 11)
1.05.1.003	Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q12	Tomo 04 · 1.3 (Pág. 11)
1.05.1.004	Hemoptisis y Bronquiectasias	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q70	Tomo 04 · 4.5 (Pág. 66)
1.05.1.005	Exacerbación Aguda de EPOC (Anthonisen)	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q17	Tomo 07 · 1.1 (Pág. 5)
1.05.1.006	Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q13	Tomo 04 · C.6 (Pág. 16)
1.05.1.007	Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q58, Q59, Q60	Tomo 04 · 4.2 (Pág. 58)
1.05.1.008	Absceso Pulmonar y Supuraciones Pleuropulmonares	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q32, Q33, Q34, Q56, Q57	Tomo 04 · 2.4 (Pág. 30)
1.05.1.009	Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q3	Tomo 04 · C.9 (Pág. 22)
1.05.1.010	Derrame Pleural: Diagnóstico Diferencial y Criterios de Light	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q38, Q39, Q40	Tomo 04 · 3.1 (Pág. 39)
1.05.1.011	Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q41, Q42, Q43, Q44, Q45	Tomo 04 · 3.2 (Pág. 41)
1.05.1.012	Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q42, Q43, Q44, Q45, Q46	Tomo 04 · 3.2 (Pág. 41)
1.05.1.013	Derrame Pleural Neoplásico y Pleuritis Tuberculosa	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q54	Tomo 04 · 3.5 (Pág. 51)
1.05.1.014	Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA): Criterios de Berlín	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q82, Q83	Tomo 04 · 5.2 (Pág. 75)
1.05.1.015	Tromboembolismo Pulmonar (TEP) Agudo: Wells, Ginebra y Estratificación	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q67, Q68	Tomo 04 · 4.4 (Pág. 62)
1.05.1.016	Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) Estable	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q15	Tomo 04 · 1.4 (Pág. 13)
1.05.1.017	Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) Estable	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q16	Tomo 04 · 1.4 (Pág. 13)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.05.1.018	Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas (EPID) y Fibrosis Pulmonar Idiopática	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q63, Q64, Q65	Tomo 04 · 4.3 (Pág. 60)
1.05.1.019	Hemoptisis y Bronquiectasias	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q71	Tomo 04 · 4.5 (Pág. 66)
1.05.1.020	Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q4	Tomo 04 · C.20 (Pág. 44)
1.05.1.021	Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q5	Tomo 04 · C.21 (Pág. 46)
1.05.1.022	Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Diagnóstico y Severidad CURB-65	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q19	Tomo 04 · C.22 (Pág. 48)
1.05.1.023	Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica)	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q75, Q76, Q77, Q78, Q79	Tomo 04 · 5.1 (Pág. 71)
1.05.1.024	Intoxicación por Monóxido de Carbono e Inhalación de Humo	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Inicial**	GES	Q87, Q88, Q89	Tomo 04 · 5.4 (Pág. 79)
1.05.1.025	Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q59, Q60, Q61	Tomo 04 · 4.2 (Pág. 58)
1.05.1.026	Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas (EPID) y Fibrosis Pulmonar Idiopática	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q64, Q65, Q66	Tomo 04 · 4.3 (Pág. 60)
1.05.1.027	Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Diagnóstico y Severidad CURB-65	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q20, Q21, Q22, Q23, Q24	Tomo 04 · 2.1 (Pág. 22)
1.05.1.028	Tratamiento Antimicrobiano de la NAC y Criterios GES	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q25, Q26	Tomo 04 · 2.2 (Pág. 26)
1.05.1.029	Neumonías Atípicas, Intrahospitalarias y Neumonía Aspirativa	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q27, Q28, Q29	Tomo 04 · 2.3 (Pág. 28)
1.05.1.030	Neumonías Atípicas, Intrahospitalarias y Neumonía Aspirativa	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q28, Q29, Q30	Tomo 04 · 2.3 (Pág. 28)
1.05.1.031	Neumotórax Espontáneo Primario y Secundario	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q47, Q48, Q49	Tomo 04 · 3.3 (Pág. 45)
1.05.1.032	Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q50, Q51	Tomo 04 · 3.4 (Pág. 47)
1.05.1.033	Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS)	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q84, Q85, Q86	Tomo 04 · 5.3 (Pág. 77)
1.05.1.034	Síndromes mediastínicos	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q55	Tomo 04 · Respiratorio (Pág. 8)
1.05.1.035	Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q14	Tomo 04 · Respiratorio (Pág. 8)
1.05.1.036	Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q35	Tomo 04 · Respiratorio (Pág. 8)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
1.05.1.037	Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q36	Tomo 04 · 2.5 (Pág. 32)
1.05.1.038	Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q59, Q60, Q62	Tomo 04 · 4.2 (Pág. 58)
1.05.2.001	Asfixia por inmersión	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q73	Tomo 04 · 5.5 (Pág. 81)
1.05.2.002	Aspiración de cuerpo extraño con asfixia	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q1	Tomo 04 · Respiratorio (Pág. 8)
1.05.2.003	Aspiración de cuerpo extraño sin asfixia	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q2	Tomo 07 · 1.3 (Pág. 11)
1.05.2.004	Crisis Asmática en el Adulto	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q8, Q9, Q10	Tomo 04 · 1.2 (Pág. 7)
1.05.2.005	Tromboembolismo Pulmonar (TEP) Agudo: Wells, Ginebra y Estratificación	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q68, Q69	Tomo 01 · 5.9 (Pág. 105)
1.05.2.006	Exacerbación Aguda de EPOC (Anthonisen)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q18	Tomo 04 · 1.5 (Pág. 15)
1.05.2.007	Hemoptisis y Bronquiectasias	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q72	Tomo 04 · 4.5 (Pág. 66)
1.05.2.008	Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica)	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q76, Q77, Q78, Q79, Q80	Tomo 04 · 5.1 (Pág. 71)
1.05.2.009	Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica)	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q76, Q77, Q78, Q79, Q81	Tomo 04 · 5.1 (Pág. 71)
1.05.2.010	Intoxicación por Monóxido de Carbono e Inhalación de Humo	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Inicial**	GES	Q88, Q89, Q90	Tomo 04 · 5.4 (Pág. 79)
1.05.2.011	Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Inicial**	GES	Q51, Q52	Tomo 04 · 3.4 (Pág. 47)
1.05.2.012	Paro cardiorespiratorio	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q74	Tomo 01 · 1.2 (Pág. 7)
1.05.2.013	Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Inicial**	GES	Q51, Q53	Tomo 04 · 3.4 (Pág. 47)
1.05.2.014	Traumatismo torácico simple	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	—	Q37	Tomo 04 · Respiratorio (Pág. 8)
1.05.4.001	Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q6, Q7	Tomo 04 · 1.1 (Pág. 5)
1.05.5.005	Nódulo Pulmonar Solitario (NPS): Evaluación y Algoritmo Fleischner	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q56, Q57	Tomo 04 · 4.1 (Pág. 56)

SECCIÓN I · CUADERNILLO DE PREGUNTAS (1 A 90)

Organizado estrictamente por Bloques Cardinales · Responda sin consultar la solución

90 ÍTEMS

BLOQUE 1 VÍA AÉREA OBSTRUCTIVA Y FUNCIÓN PULMONAR

PREGUNTA 1 1.05.2.002

1. **[URGENCIA: Aspiración de cuerpo extraño con asfixia · 1.05.2.002] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Aspiración de cuerpo extraño con asfixia. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 2 1.05.2.003

2. **[URGENCIA: Aspiración de cuerpo extraño sin asfixia · 1.05.2.003] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Aspiración de cuerpo extraño sin asfixia. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 3 1.05.1.009

3. **Mujer de 56 años cardiópata y con fibrilación auricular crónica, en tratamiento con espironolactona, isosorbide, hidralazina, amiodarona y anticoagulante oral. Inicia hace 6 meses un cuadro de disnea y tos seca. A la exploración pulmonar tiene crépitos bibasales. Se solicita una radiografía de tórax, que se muestra a continuación: ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A) Suspender amiodarona

B) Solicitar TAC de tórax

C) Aumentar diurético

D) Solicitar ecocardiograma

E) Solicitar fibrobroncoscopia

PREGUNTA 4 1.05.1.020

4. **Paciente con expectoración hemoptoica y eliminación de contenido 'en uvas'. Radiografía con imagen compatible. ¿Diagnóstico más probable?**

A) Quiste hidatídico pulmonar

B) Absceso pulmonar

C) Bronquiectasias

D) Cáncer pulmonar cavitado

E) Aspergilosis pulmonar invasiva

PREGUNTA 5 1.05.1.021

5. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Hipertensión pulmonar · 1.05.1.021] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Hipertensión pulmonar. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.

B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.

C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.

D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.

E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 6 1.05.4.001

6. Un paciente de 26 años con antecedentes de rinitis alérgica consulta por episodios recurrentes de tos seca nocturna y disnea sibilante tras realizar ejercicio. Se realiza una espirometría basal que muestra VEF1/CVF de 0.64 y VEF1 del 68% del teórico. Tras la inhalación de 400 mcg de salbutamol, el VEF1 asciende al 84% del predicho, con un incremento absoluto de 420 mL. ¿Cuál es la interpretación diagnóstica más adecuada?

A) Patrón restrictivo pulmonar puro secundario a hiperreactividad
B) Patrón obstructivo con respuesta broncodilatadora significativa compatible con asma
C) Obstrucción fija de la vía aérea que descarta asma bronquial
D) Espirometría no interpretable que exige solicitar pletismografía inmediata
E) Patrón mixto con atrapamiento aéreo severo

PREGUNTA 7 1.05.4.001

7. Un paciente de 60 años con disnea de esfuerzo en estudio presenta una espirometría con VEF1/CVF de 0.82, VEF1 del 62% del valor predicho y CVF del 60% del predicho. ¿Cuál es la conducta médica de elección para certificar el diagnóstico funcional?

A) Iniciar salmeterol con fluticasona por patrón obstructivo leve
B) Solicitar pletismografía corporal para medir Capacidad Pulmonar Total (CPT)
C) Realizar test de provocación con metacolina en forma ambulatoria
D) Asumir diagnóstico definitivo de fibrosis pulmonar e iniciar pirfenidona
E) Repetir la espirometría tras ciclo de prednisona oral por 14 días

PREGUNTA 8 1.05.2.004

8. Un paciente de 25 años, con antecedente de asma en tratamiento con flu8casona, un puff cada 12 horas, y salbutamol SOS, consulta por un cuadro de disnea que inició hace 48 horas en relación a un cuadro respiratorio alto y que ha ido empeorando, presentando actualmente disnea de mínimos esfuerzos que no ha respondido al uso de salbutamol. Al examen Fsico se observa taquipneico, con aumento del diámetro anteroposterior del tórax, frecuencia respiratoria de 35 por minuto, saturación de oxígeno 95% y frases con palabras entrecortadas. ¿Cuál de los siguientes exámenes es más adecuado para precisar la severidad del cuadro?

A) Radiogra:a de tórax
B) Test de metacolina
C) Flujo espiratorio máximo (PEF)
D) Hemograma y VHS
E) Gases en sangre venosa

PREGUNTA 9 1.05.2.004

9. Un joven de 19 años es llevado al servicio de urgencias por una crisis asmática severa. Al ingreso se encuentra somnoliento, sudoroso, con respiración paradójica y a la auscultación pulmonar llama la atención un murmullo pulmonar globalmente disminuido sin sibilancias audibles ("tórax silente"). Los gases arteriales muestran: pH 7.28, PaO2 55 mmHg, PaCO2 48 mmHg y HCO3 22 mEq/L. ¿Cuál es la interpretación fisiopatológica y la conducta más prioritaria?

A) Mejoría clínica espontánea por ausencia de sibilancias; mantener observación con salbutamol en dosis bajas
B) Agotamiento diafragmático con riesgo vital inminente de paro respiratorio; preparar intubación endotraqueal
C) Ataque de pánico con hiperventilación psicógena; administrar alprazolam oral
D) Acidosis metabólica láctica primaria; administrar 100 mL de bicarbonato de sodio EV
E) Crisis leve-moderada compensada; nebulizar con suero fisiológico exclusivo

PREGUNTA 10 1.05.2.004

10. Una paciente de 30 años consulta por disnea sibilante de 6 horas de evolución. Presenta FR 24 rpm, FC 98 lpm, SatO2 94% ambiental y PEF del 62% del valor predicho. Tras recibir salbutamol 4 puff cada 20 minutos por 3 veces y 40 mg de prednisona oral, se encuentra asintomática, con SatO2 97% y PEF del 78%. ¿Cuál es la indicación farmacológica de egreso más apropiada?

A) Salbutamol a demanda exclusivo sin corticoides ambulatorios
B) Prednisona oral 40 mg al día por 5 días más salbutamol de rescate y control médico
C) Ciclo de prednisona oral por 30 días con reducción progresiva semanal
D) Amoxicilina más ácido clavulánico 875/125 mg cada 12 horas por 7 días
E) Teofilina de liberación prolongada 200 mg cada 12 horas

PREGUNTA 11 1.05.1.002

11. Una paciente de 24 años con asma bronquial consulta a control en su CESFAM. Utiliza actualmente fluticasona 125 mcg cada 12 horas más salbutamol SOS. En las últimas 4 semanas refiere haber presentado tos y sibilancias 3 veces por semana, un despertar nocturno por disnea y necesidad de salbutamol 3 veces por semana. No ha tenido limitaciones en su trabajo. ¿Cómo clasifica su nivel de control y cuál es la conducta clínica inicial?

A) Asma bien controlada; reducir la fluticasona a la mitad
B) Asma parcialmente controlada; revisar técnica inhalatoria y adherencia antes de escalar a CI + LABA
C) Asma no controlada; iniciar de inmediato prednisona oral 40 mg al día por 1 mes
D) Asma refractaria grave; derivar a nivel secundario para estudio con anticuerpos monoclonales
E) Crisis asmática subaguda; hospitalizar en sala de medicina interna

PREGUNTA 12 1.05.1.003

12. **Un paciente de 58 años, fumador de 10 paquetes año, consulta por disnea, asociada a tos y expectoración mucosa. Los síntomas aumentan especialmente en relación a la actividad física y cuando presenta infecciones respiratorias. En su examen físico se auscultan escasas sibilancias bilaterales y espiración prolongada. Se solicita una espirometría que muestra: Basal Postbroncodilatador CVF 5.928cc 100% 6.106cc 103% VEF1 4.163cc 76% 5.040cc 92% VEF1/CVF 65% 73% Su radiografía de tórax se muestra a continuación: El diagnóstico más probable es:**

A) Asma bronquial
B) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
C) Bronquiectasias
D) Bronquitis crónica
E) Enfermedad pulmonar intersticial difusa

PREGUNTA 13 1.05.1.006

13. **Un paciente de 66 años, fumador de 40 paquetes-año presenta tos con expectoración mucosa, de 4 años de evolución. Tiene broncorrea, mayor en la mañana y presenta 2 infecciones respiratorias al año, que requieren de antibióticos. Su radiografía de tórax y espirometría son normales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Cáncer de pulmón
B) Tuberculosis pulmonar
C) Fibrosis pulmonar
D) EPOC
E) Bronquitis crónica

PREGUNTA 14 1.05.1.035

14. **Un paciente de 36 años consulta por sensación de opresión precordial y tos, que son más intensas en la noche. Además, refiere disfonía y rinorrea, que se exacerbó durante la primavera. El examen físico no aporta mayor información. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Iniciar omeprazol oral
B) Iniciar antihistamínicos orales
C) Iniciar corticoides orales
D) Iniciar antibióticos orales
E) Iniciar AINEs orales

PREGUNTA 15 1.05.1.016

15. **Un paciente de 68 años con diagnóstico de EPOC avanzado acude a control en el policlínico broncopulmonar. Se encuentra en reposo, en fase estable. Su gasometría arterial respirando aire ambiental muestra: pH 7.38, PaO2 53 mmHg, PaCO2 46 mmHg y SatO2 86%. ¿Cuál de las siguientes intervenciones ha demostrado prolongar la supervivencia en este paciente?**

A) Terapia triple con fluticasona, salmeterol y tiotropio
B) Oxigenoterapia continua domiciliaria al menos 15 horas al día
C) Ciclos mensuales de azitromicina oral en dosis profiláctica
D) Teofilina oral de liberación retardada
E) Nebulizaciones diarias con solución salina hipertónica al 7%

PREGUNTA 16 1.05.1.017

16. **Espirometría con VEF1/CVF 0.35, no mejora post broncodilatador, VEF1 50%**

A) Fibrosis pulmonar
B) Insuficiencia cardiaca derecha
C) EPOC
D) Asma
E) Bronquiectasias

PREGUNTA 17 1.05.1.005

17. **[ATENCIÓN PRIMARIA: Bronquitis aguda · 1.05.1.005] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Bronquitis aguda. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?**

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 18 1.05.2.006

18. **Un paciente de 67 años, con antecedente de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en tratamiento con broncodilatadores inhalados, evoluciona con aumento importante de su disnea basal, asociado a cianosis y angustia. El paciente está vigil y orientado y en su examen físico tiene FR: 35x', PA: 110/76 mmHg, FC: 110x' y al examen pulmonar se aprecia uso de musculatura accesoria, cianosis, aumento del diámetro anteroposterior y sibilancias y roncus intensos bilaterales. Su radiografía de tórax se muestra más abajo (fuente: radiopaedia). Se ingresa al servicio de urgencia, recibiendo antibióticos y nebulizaciones con broncodilatadores por una hora, sin mejoría clínica. Se solicitan gases arteriales, que resultan PaCO2: 62 mmHg, PaO2: 56 mmHg, pH:7,29 y HCO3: 27 mEq/L. La conducta más adecuada, a continuación, es:**

A) Ventilación mecánica invasiva
B) Aminofilina endovenosa
C) Oxígeno por cánula nasal de alto flujo
D) Ventilación no invasiva
E) Bicarbonato de sodio endovenoso

BLOQUE 2 INFECCIONES RESPIRATORIAS BAJAS Y SUPURACIONES

PREGUNTA 19 1.05.1.022

19. Un paciente de 38 años consulta por malestar general y fiebre de 3 días de evolución, asociada a mialgias, tos seca y rinorrea mucosa abundante. Al examen físico tiene secreción nasal y faringe congestiva y eritematosa. ¿Cuál es el fármaco más adecuado para el manejo de este paciente?

A) Amoxicilina
B) Aciclovir
C) Acetaminofeno
D) Claritromicina
E) Prednisona

PREGUNTA 20 1.05.1.027

20. Una paciente de 45 años, hipertensa, presenta un cuadro de 4 días de evolución de malestar general, fiebre hasta 38,8°C, mialgias, cefalea y tos con expectoración mucopuruleta. Al examen físico tiene FR: 13 lpm, FC: 80x'. PA: 120/80 mmHg, examen pulmonar con crépitos en la base izquierda, matidez y aumento de la trasmisión de las vibraciones vocales en la zona. Examen cardíaco normal. Satura 98% a FiO2 ambiental y se solicita una radiografía, que se muestra a continuación: Fuente: www.learningradiology.com ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Oseltamivir
B) Levofloxacino
C) Ceftriaxona
D) Amoxicilina
E) Claritromicina

PREGUNTA 21 1.05.1.027

21. Un hombre de 68 años consulta en el servicio de urgencias por compromiso del estado general, tos con expectoración purulenta y fiebre de 39 °C. Al examen físico se encuentra desorientado en tiempo y espacio, con FR de 34 rpm, PA 85/50 mmHg, FC 118 lpm y crepitaciones en la base pulmonar izquierda. La radiografía de tórax confirma una consolidación basal izquierda. El nitrógeno ureico en sangre (BUN) es de 28 mg/dL. ¿Cuál es el puntaje CURB-65 y la conducta de internación más adecuada?

A) CURB-65 de 2 puntos; hospitalización en sala de medicina general
B) CURB-65 de 3 puntos; manejo ambulatorio con control en 24 horas
C) CURB-65 de 5 puntos; hospitalización inmediata en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)
D) CURB-65 de 1 punto; tratamiento ambulatorio con levofloxacino
E) CURB-65 de 4 puntos; hospitalización en sala intermedia sin monitorización

PREGUNTA 22 1.05.1.027

22. ¿Cuál es el examen complementario indispensable para confirmar el diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad en un adulto con clínica compatible?

A) Tomografía computarizada de tórax de alta resolución
B) Radiografía de tórax anteroposterior y lateral
C) Tinción de Gram y cultivo de esputo
D) Proteína C reactiva y procalcitonina cuantitativa
E) Espirometría basal

PREGUNTA 23 1.05.1.027

23. Hombre de 66 años, sin antecedentes mórbidos conocidos, consulta en un centro de salud familiar por cuadro de 48 horas de fiebre hasta 38.5 °C, tos productiva con esputo amarillento y dolor pleurítico en hemitórax derecho. Al examen: vigil, orientado en tiempo y espacio, FC 84 lpm, PA 126/78 mmHg, FR 20 rpm, SatO2 96% ambiental. Murmullo pulmonar conservado con crépitos inspiratorios en base derecha. BUN 12 mg/dL. Radiografía de tórax: infiltrado alveolar basal derecho. ¿Cuál es el puntaje CURB-65 y la conducta recomendada?

A) CURB-65 = 0 puntos; manejo sintomático con paracetamol sin antibióticos
B) CURB-65 = 1 punto; tratamiento ambulatorio con amoxicilina/ácido clavulánico oral y control clínico en 48 horas
C) CURB-65 = 2 puntos; hospitalización obligatoria en sala de cuidados medios
D) CURB-65 = 1 punto; derivación inmediata a urgencias para administración de ceftriaxona endovenosa
E) CURB-65 = 3 puntos; ingreso directo a Unidad de Cuidados Intensivos

PREGUNTA 24 1.05.1.027

24. ¿Cuál de los siguientes criterios clínicos constituye un criterio mayor de la Sociedad Americana del Tórax (ATS/IDSA) que define por sí solo el ingreso directo a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en un paciente con neumonía adquirida en la comunidad?

A) Frecuencia respiratoria superior a 30 respiraciones por minuto
B) Presencia de infiltrados alveolares multilobares en la radiografía de tórax
C) Shock séptico con necesidad de soporte con vasopresores a pesar de resucitación con fluidos
D) Relación PaO2/FiO2 menor o igual a 250
E) Confusión mental aguda con desorientación témporo-espacial

PREGUNTA 25 1.05.1.028

25. Una mujer de 69 años con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial consulta en el CESFAM por fiebre de 38.5 °C, tos productiva y decaimiento de 48 horas. Al examen: orientada, PA 135/85 mmHg, FC 88 lpm, FR 20 rpm, SatO2 95% ambiental. La radiografía de tórax confirma neumonía basal derecha. ¿Cuál es el esquema antibiótico ambulatorio de primera línea según las guías clínicas ministeriales (GES)?

A) Ceftriaxona 1 g intramuscular al día por 14 días
B) Amoxicilina con ácido clavulánico 875/125 mg cada 12 horas por vía oral durante 7 días
C) Amoxicilina 500 mg cada 8 horas por vía oral por 3 días
D) Ciprofloxacino 500 mg cada 12 horas por vía oral por 10 días
E) Cotrimoxazol fuerte 1 comprimido cada 12 horas por 14 días

PREGUNTA 26 1.05.1.028

26. **Un paciente de 58 años ingresa a sala de medicina interna por una neumonía adquirida en la comunidad CURB-65 = 2. Recibe ceftriaxona 1 g EV al día. Al cuarto día de hospitalización se encuentra afebril desde hace 48 horas, con FR 16 rpm, FC 74 lpm, PA 125/80 mmHg y SatO2 96% ambiental, tolerando alimentación por boca. ¿Cuál es la conducta terapéutica correcta?**

A) Mantener la ceftriaxona endovenosa hasta completar estrictamente 14 días
B) Realizar switch a antibiótico oral ambulatorio (ej. amoxicilina/clavulánico o cefuroximo) para completar 7 días totales
C) Suspender antibióticos y solicitar nueva radiografía de tórax para comprobar la resolución del infiltrado antes del alta
D) Cambiar ceftriaxona a vancomicina oral profiláctica
E) Tomar broncoscopía con lavado broncoalveolar para cultivo

PREGUNTA 27 1.05.1.029

27. **Un paciente de 34 años, consulta por cuadro de 5 semanas de tos irritativa y expectoración que ha ido empeorando, agregándose disnea de medianos esfuerzos. Al examen físico se aprecia enflaquecido, con frecuencia respiratoria de 27 por minuto, frecuencia cardiaca de 90 por minuto, presión arterial de 100/70 mmHg y saturación de 92% con FiO2 ambiental. Examen pulmonar muestra crepitaciones, estertores y algunas sibilancias bilaterales. Se solicita radiografía que se muestra a continuación: El diagnóstico más probable es:**

A) Fibrosis pulmonar
B) Asma bronquial
C) Neumonitis viral
D) Neumonía por mycoplasma
E) Neumonía por Pneumocystis jiroveci

PREGUNTA 28 1.05.1.029, 1.05.1.030

28. **Un paciente de 62 años con antecedente de etilismo crónico severo sufre un episodio de pérdida de conciencia tras ingesta alcohólica copiosa. Tres días después consulta por fiebre de 38.8 °C, tos con expectoración purulenta de olor fétido y dolor torácico derecho. La radiografía de tórax muestra una condensación con broncograma aéreo en el segmento apical del lóbulo inferior derecho. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico empírico más adecuado?**

A) Azitromicina 500 mg al día por vía oral
B) Ampicilina/sulbactam endovenoso
C) Ciprofloxacino en monoterapia oral
D) Amikacina en bolo intramuscular diario
E) Fluconazol endovenoso

PREGUNTA 29 1.05.1.029, 1.05.1.030

29. **Un paciente de 74 años ingresa a medicina por una hemorragia digestiva alta. Al quinto día de hospitalización inicia fiebre de 38.6 °C, taquipnea, desaturación y estertores crepitantes en ambos hemitórax. La radiografía de tórax muestra infiltrados nuevos en base pulmonar izquierda. ¿Cuál es la conducta diagnóstica y terapéutica más apropiada?**

A) Diagnóstico de NAC atípica; tratar con eritromicina oral por 7 días
B) Diagnóstico de Neumonía Intrahospitalaria (NIH); iniciar hemocultivos y antibióticos antipseudomónicos como piperacilina/tazobactam
C) Diagnóstico de embolia grasa; administrar corticoides a altas dosis
D) Diagnóstico de bronquitis aguda viral; mantener observación sin antimicrobianos
E) Diagnóstico de edema pulmonar cardiogénico; suspender fluidos e indicar amoxicilina oral

PREGUNTA 30 1.05.1.030

30. **Un paciente de 62 años con antecedente de etilismo crónico severo sufre un episodio de pérdida de conciencia tras ingesta alcohólica copiosa. Tres días después consulta por fiebre de 38.8 °C, tos con expectoración purulenta de olor fétido y dolor torácico derecho. La radiografía de tórax muestra una condensación con broncograma aéreo en el segmento apical del lóbulo inferior derecho. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico empírico más adecuado?**

A) Azitromicina 500 mg al día por vía oral
B) Ampicilina/sulbactam endovenoso
C) Ciprofloxacino en monoterapia oral
D) Amikacina en bolo intramuscular diario
E) Fluconazol endovenoso

PREGUNTA 31 1.05.1.001

31. **Un paciente alcohólico, fumador de 10 paquetes año, presenta, desde hace 7 días, un cuadro de tos, con expectoración purulenta y fiebre hasta 38°C. Ha evolucionado con empeoramiento de los síntomas. Al examen físico está febril, con apremio respiratorio. Se solicita una radiografía de tórax, que se muestra a continuación: El examen más adecuado para proseguir el estudio es:**

A) Broncoscopía
B) Videotoracoscopía
C) TAC de tórax
D) PET-TC
E) Resonancia magnética nuclear de tórax

PREGUNTA 32 1.05.1.001, 1.05.1.008

32. Un hombre de 55 años con antecedente de etilismo crónico consulta por tos productiva con esputo purulento muy maloliente, fiebre vespertina y baja de peso de un mes de evolución. La radiografía de tórax muestra una lesión redondeada de 5 cm de diámetro con nivel hidroaéreo y paredes gruesas en el lóbulo superior derecho. ¿Cuál es el tratamiento inicial de elección?

A) Toracotomía de urgencia con resección del lóbulo afectado
B) Tratamiento antibiótico médico prolongado con ampicilina/sulbactam (o amoxicilina/clavulánico) por 4 a 6 semanas
C) Instalación percutánea obligatoria de un tubo de drenaje pleural grueso
D) Ciprofloxacino oral por 7 días y reevaluación
E) Punción aspirativa con aguja fina bajo control ecográfico

PREGUNTA 33 1.05.1.001, 1.05.1.008

33. ¿Cuál de los siguientes hallazgos clínicos o radiológicos en un paciente con una imagen cavitada en el pulmón obliga a sospechar un carcinoma epidermoide cavitado antes que un absceso bacteriano simple?

A) Presencia de esputo fétido con olor a putrefacción
B) Paredes internas de la cavidad sumamente gruesas e irregulares con nodulaciones parietales en la TAC
C) Aparición aguda en menos de 48 horas con fiebre alta
D) Resolución completa de la lesión tras dos semanas de penicilina
E) Antecedente de extracción de piezas dentales hace 10 días

PREGUNTA 34 1.05.1.008

34. Un hombre de 55 años con antecedente de etilismo crónico consulta por tos productiva con esputo purulento muy maloliente, fiebre vespertina y baja de peso de un mes de evolución. La radiografía de tórax muestra una lesión redondeada de 5 cm de diámetro con nivel hidroaéreo y paredes gruesas en el lóbulo superior derecho. ¿Cuál es el tratamiento inicial de elección?

A) Toracotomía de urgencia con resección del lóbulo afectado
B) Tratamiento antibiótico médico prolongado con ampicilina/sulbactam (o amoxicilina/clavulánico) por 4 a 6 semanas
C) Instalación percutánea obligatoria de un tubo de drenaje pleural grueso
D) Ciprofloxacino oral por 7 días y reevaluación
E) Punción aspirativa con aguja fina bajo control ecográfico

PREGUNTA 35 1.05.1.036

35. Un paciente de 42 años consulta por tos de un mes de evolución, sin expectoración. Su esposa está en tratamiento antituberculoso. Su examen físico muestra crépitos escasos bilaterales. Se realizaron baciloscopías de expectoración, que resultan negativas; quantiferón para tuberculosis, que resulta positivo; y radiografía de tórax, que se muestra a continuación (fuente: radiopaedia): La conducta más adecuada es:

A) Iniciar profilaxis antituberculosa
B) Solicitar reacción de cadena de polimerasa para tuberculosis en expectoración
C) Iniciar tratamiento antibiótico antituberculoso
D) Solicitar cultivo de Koch
E) Solicitar PPD

PREGUNTA 36 1.05.1.037

36. Un paciente de 45 años diagnosticado de tuberculosis pulmonar bacilífera inicia tratamiento con el esquema estándar RHZE bajo supervisión directa. A las 4 semanas de tratamiento consulta refiriendo disminución progresiva de la agudeza visual y dificultad para distinguir las luces del semáforo, refiriendo ver los colores deslavados. ¿Cuál de los fármacos del esquema es el responsable más probable de este cuadro?

A) Isoniazida
B) Rifampicina
C) Etambutol
D) Pirazinamida
E) Estreptomicina

BLOQUE 3 PATOLOGÍA PLEURAL Y URGENCIAS TORÁCICAS

PREGUNTA 37 1.05.2.014

37. [URGENCIA: Traumatismo torácico simple · 1.05.2.014] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Traumatismo torácico simple. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 38 1.05.1.010

38. **Un paciente de 56 años, fumador de 20 paquetes año, consulta por disnea progresiva de 2 meses de evolución, asociada a tos irritativa y compromiso del estado general. Sus signos vitales son FC: 88x', PA: 130/80 mmHg, saturación 93% a FiO2 ambiental y al examen pulmonar presenta matidez y crépitos en la base derecha. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra un derrame pleural moderado, a derecha, el que se confirma con la TAC de tórax. Se realiza toracocentesis, que da salida a un líquido pleural opalescente, con LDH: 700 UI/L, mayor a 0,6 en relación a la LDH plasmática y proteínas mayores a 0,5, en relación a las proteínas plasmáticas, con 40 células por mm3, 90% de mononucleares, ADA: 24 UI/L y citología negativa. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio?**

A) Biopsia pulmonar por videotoracoscopía
B) Broncoscopía con biopsia pulmonar
C) PET-TC
D) Biopsia pleural por videotoracoscopía
E) Broncoscopía con lavado bronquioalveolar

PREGUNTA 39 1.05.1.010

39. **Se realiza una toracocentesis a un paciente de 70 años hospitalizado por disnea en estudio que presenta derrame pleural derecho. Los resultados del líquido pleural y sérico simultáneo arrojan: Proteínas en líquido pleural 2.1 g/dL, Proteínas en suero 6.4 g/dL; LDH en líquido pleural 90 U/L, LDH en suero 210 U/L (límite superior normal de LDH sérica: 200 U/L). ¿Cuál es la clasificación del líquido pleural y la etiología más probable?**

A) Exudado; empiema paraneumónico
B) Exudado; adenocarcinoma metastásico
C) Trasudado; insuficiencia cardíaca congestiva o cirrosis descompensada
D) Exudado; pleuritis lúpica
E) Quilotórax traumático

PREGUNTA 40 1.05.1.010

40. **¿Cuál de los siguientes hallazgos al examen físico pulmonar es característico de un derrame pleural moderado a severo en la base pulmonar comprometida?**

A) Aumento de las vibraciones vocales y timpanismo marcado
B) Disminución de las vibraciones vocales, matidez a la percusión y abolición del murmullo vesicular
C) Resonancia vocal incrementada (broncofonía) con estertores húmedos bilaterales
D) Frote pericárdico con murmullo pulmonar conservado
E) Sonoridad pulmonar aumentada con respiración ruda y sibilancias difusas

PREGUNTA 41 1.05.1.011

41. **Un paciente de 50 años presenta un cuadro clínico de 7 días de evolución, caracterizado por tos con expectoración mucopurulenta abundante y fiebre de hasta 38,7°C. El examen físico muestra disminución del murmullo pulmonar, con abolición del murmullo pulmonar en la base derecha. La radiografía de tórax muestra signos de condensación en el lado derecho y derrame pleural de tamaño moderado Se inicia tratamiento con ceftriaxona 2g al día y se realiza toracocentesis, obteniéndose un líquido pleural con 2.000 células/mm3, 85% de polimorfonucleares, colesterol: 70 mg/dL, LDH: 220 U/L, pH: 7.26 y lactato de 6.1 mmol/L. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar drenaje completo del derrame pleural
B) Agregar metronidazol al tratamiento
C) Solicitar TAC de tórax
D) Solicitar baciloscopías de expectoración
E) Realizar broncoscopia y biopsia

PREGUNTA 42 1.05.1.011, 1.05.1.012

42. **Un paciente de 62 años hospitalizado hace 4 días por neumonía comunitaria en tratamiento con ceftriaxona endovenosa persiste con picos febriles de 38.8 °C y marcado compromiso del estado general. La ecografía torácica evidencia un derrame pleural de 300 mL en la base derecha. Se realiza toracocentesis diagnóstica obteniendo líquido turbio cuyo análisis muestra: pH 7.14, glucosa 32 mg/dL, LDH 2.200 U/L, proteínas 4.5 g/dL. La tinción de Gram inmediata no observa bacterias. ¿Cuál es la conducta médica de elección más prioritaria?**

A) Mantener ceftriaxona en la misma dosis y repetir la punción diagnóstica en 48 horas
B) Instalar de inmediato un tubo de drenaje torácico conectado a trampa de agua
C) Suspender ceftriaxona e iniciar monoterapia con ciprofloxacino oral
D) Indicar toracotomía abierta de urgencia con decorticación pulmonar
E) Realizar kinesioterapia respiratoria intensiva y administrar diuréticos de asa

PREGUNTA 43 1.05.1.011, 1.05.1.012

43. **¿Cuál de los siguientes parámetros del análisis físico-químico del líquido pleural es el indicador individual más confiable y determinante para decidir la instalación de un tubo de drenaje pleural en un derrame paraneumónico?**

A) Recuento absoluto de glóbulos blancos mayor a 10.000/uL
B) pH del líquido pleural inferior a 7.20
C) Relación de proteínas líquido pleural / suero mayor a 0.5
D) Nivel de amilasa pleural elevado al doble del plasma
E) Concentración de adenosina deaminasa (ADA) superior a 30 U/L

PREGUNTA 44 1.05.1.011, 1.05.1.012

44. **Hombre de 48 años con antecedentes de enolismo crónico es diagnosticado de empiema pleural derecho con abundante pus espeso y fétido al examen de toracocentesis. Se instala un tubo de drenaje pleural 28 Fr con salida inicial de 400 mL de material purulento. ¿Cuál es la terapia antimicrobiana parenteral de primera línea más adecuada?**

A) Ciprofloxacino en monoterapia
B) Ampicilina / Sulbactam endovenoso (o Ceftriaxona asociada a Metronidazol)
C) Gentamicina endovenosa en dosis única diaria
D) Amoxicilina oral 500 mg cada 8 horas
E) Azitromicina endovenosa exclusiva

PREGUNTA 45 1.05.1.011, 1.05.1.012

45. **Paciente de 55 años con empiema pleural derecho complicado tiene instalado un tubo de drenaje torácico hace 48 horas. Sin embargo, el débito ha disminuido a menos de 50 mL/día a pesar de persistir con fiebre de 38.5 °C y leucocitosis de 18.000/uL. La ecografía torácica de control demuestra múltiples tabiques gruesos de fibrina con colecciones loculadas que no comunican con el tubo. ¿Cuál es el paso terapéutico más indicado?**

A) Retirar el tubo de tórax y mantener únicamente antibioticoterapia oral en domicilio
B) Instilación intrapleural de fibrinolíticos combinados (t-PA más DNAsa) o resolución por videotoracoscopía (VATS)
C) Punción pleural diaria repetida con aguja fina en la consulta
D) Aumentar la hidratación parenteral a 4.000 mL de suero fisiológico al día
E) Indicar reposo absoluto y esperar 14 días para la reabsorción espontánea

PREGUNTA 46 1.05.1.012

46. **Un paciente de 50 años presenta un cuadro de tos, con expectoración mucopurulenta y fiebre. Al examen físico está se auscultan crepitaciones basales. Se solicita una radiografía de tórax, que se muestra más abajo: NOTA: la radiografía mostraba infiltrados en la base izquierda, que ocupaban el lóbulo inferior izquierdo, pero que permitían ver la cúpula diafragmática, con un pequeño derrame pleural, limitado al ángulo costofrénico. Se punciona el derrame pleural, que muestra un lactato: 2,4 mmol/L, pH: 7,34, con 350 células, 90% de polimorfonucleares. ¿Qué antibiótico debe dejar?**

A) Claritromicina
B) Clindamicina
C) Ceftriaxona
D) Azitromicina
E) Amoxicilina

PREGUNTA 47 1.05.1.031

47. **Paciente de 18 años, sin antecedentes mórbidos, es traído al servicio de urgencias por cuadro de dolor en hemitórax izquierdo de inicio súbito irradiado a miembro superior ipsilateral, asociado a disnea leve, el cual inició mientras jugaba un partido de basquetbol. Al examen físico se aprecia en buenas condiciones y a la auscultación pulmonar destaca disminución del murmullo pulmonar en hemitórax izquierdo, sin otros síntomas. El diagnóstico más probable es:**

A) Angina inestable
B) Tromboembolismo pulmonar
C) Neumotorax espontáneo
D) Perforación esofágica
E) Contractura muscular

PREGUNTA 48 1.05.1.031

48. **Un joven de 21 años, deportista, sin antecedentes mórbidos, consulta en urgencias por dolor torácico pleurítico izquierdo agudo iniciado en reposo. Al examen físico: SatO2 99% respirando aire ambiental, FR 16 rpm, PA 118/70 mmHg, murmullo pulmonar levemente disminuido en el ápice izquierdo. La radiografía de tórax muestra una franja de aire apical de 1.2 cm en el hemitórax izquierdo sin desviación mediastínica. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A) Instalación inmediata de un tubo de drenaje pleural número 28 Fr con trampa de agua
B) Toracotomía exploradora de urgencia para resección de bullas
C) Administración de oxígeno suplementario, reposo en observación por 4 a 6 horas y control radiológico
D) Punción pleural descompresiva en el segundo espacio intercostal con bránula 14G
E) Alta inmediata sin necesidad de reposo ni seguimiento

PREGUNTA 49 1.05.1.031

49. **¿En cuál de las siguientes situaciones clínicas está formalmente indicada la resolución quirúrgica mediante videotoracoscopía (VATS) y pleurodesis en un paciente con neumotórax espontáneo primario?**

A) Primer episodio de neumotórax primario de 1 cm resuelto favorablemente
B) Segundo episodio de neumotórax en el mismo hemitórax (recurrencia homolateral)
C) Paciente fumador pasivo con tos crónica sin neumotórax
D) Presencia de dolor pleurítico residual leve a los 3 días del alta
E) Aparición de frote pleural durante la fase de reexpansión

PREGUNTA 50 1.05.1.032

50. **Un paciente de 28 años consulta por dolor torácico derecho, de 2 días de evolución, que aumenta con la inspiración y con la actividad física. Al examen físico está eupneico, con FR: 15x', saturación de oxígeno normal, se aprecia disminución del murmullo pulmonar mayor en el lado derecho. Se solicita una radiografía, que se muestra a continuación (Fuente: imgur.com): ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Control radiológico en 24 horas
B) Solicitar TAC de tórax
C) Realizar cirugía abierta
D) Drenaje con tubo pleural
E) Realizar videotoracoscopía

PREGUNTA 51 1.05.1.032, 1.05.2.011, 1.05.2.013

51. Un paciente de 35 años ingresa al servicio de urgencias tras sufrir una herida por arma blanca en el hemitórax derecho. Al examen físico se encuentra estuporoso, pálido, con sudoración fría, PA de 70/40 mmHg, FC de 135 lpm y saturación de 82% con oxígeno ambiental. Se observan venas del cuello ingurgitadas a tensión, la tráquea está visiblemente desviada hacia la izquierda y a la auscultación hay silencio pulmonar en todo el hemitórax derecho con hipersonoridad percutoria. ¿Cuál es la conducta médica más prioritaria e inaplazable?

A) Trasladar de inmediato al paciente al servicio de radiología para una radiografía de tórax portátil
B) Realizar descompresión torácica inmediata con aguja gruesa en el segundo espacio intercostal línea medioclavicular derecha
C) Intubación orotraqueal con inducción de secuencia rápida y ventilación a presión positiva
D) Administrar 2.000 mL de solución fisiológica en bolo rápido por dos vías venosas periféricas
E) Realizar pericardiocentesis subxifoidea de urgencia

PREGUNTA 52 1.05.2.011

52. Un paciente de 35 años ingresa al servicio de urgencias tras sufrir una herida por arma blanca en el hemitórax derecho. Al examen físico se encuentra estuporoso, pálido, con sudoración fría, PA de 70/40 mmHg, FC de 135 lpm y saturación de 82% con oxígeno ambiental. Se observan venas del cuello ingurgitadas a tensión, la tráquea está visiblemente desviada hacia la izquierda y a la auscultación hay silencio pulmonar en todo el hemitórax derecho con hipersonoridad percutoria. ¿Cuál es la conducta médica más prioritaria e inaplazable?

A) Trasladar de inmediato al paciente al servicio de radiología para una radiografía de tórax portátil
B) Realizar descompresión torácica inmediata con aguja gruesa en el segundo espacio intercostal línea medioclavicular derecha
C) Intubación orotraqueal con inducción de secuencia rápida y ventilación a presión positiva
D) Administrar 2.000 mL de solución fisiológica en bolo rápido por dos vías venosas periféricas
E) Realizar pericardiocentesis subxifoidea de urgencia

PREGUNTA 53 1.05.2.013

53. Un paciente de 35 años ingresa al servicio de urgencias tras sufrir una herida por arma blanca en el hemitórax derecho. Al examen físico se encuentra estuporoso, pálido, con sudoración fría, PA de 70/40 mmHg, FC de 135 lpm y saturación de 82% con oxígeno ambiental. Se observan venas del cuello ingurgitadas a tensión, la tráquea está visiblemente desviada hacia la izquierda y a la auscultación hay silencio pulmonar en todo el hemitórax derecho con hipersonoridad percutoria. ¿Cuál es la conducta médica más prioritaria e inaplazable?

A) Trasladar de inmediato al paciente al servicio de radiología para una radiografía de tórax portátil
B) Realizar descompresión torácica inmediata con aguja gruesa en el segundo espacio intercostal línea medioclavicular derecha
C) Intubación orotraqueal con inducción de secuencia rápida y ventilación a presión positiva
D) Administrar 2.000 mL de solución fisiológica en bolo rápido por dos vías venosas periféricas
E) Realizar pericardiocentesis subxifoidea de urgencia

PREGUNTA 54 1.05.1.013

54. Un paciente de 29 años presenta un cuadro de 1 mes de evolución de astenia, febrícula y tope inspiratorio derecho. La radiografía muestra derrame pleural derecho moderado. El estudio del líquido pleural confirma un exudado seroso con 92% de células mononucleares (linfocitos), glucosa de 68 mg/dL y un nivel de ADA pleural de 62 U/L. La tinción de Ziehl-Neelsen del líquido pleural no observa bacilos ácido-alcohol resistentes. ¿Cuál es el examen confirmatorio con mayor rendimiento diagnóstico para esta patología?

A) Repetir la baciloscopía del líquido pleural en tres muestras consecutivas
B) Biopsia pleural percutánea con aguja para estudio histopatológico y cultivo
C) PPD (tuberculina) dérmico exclusiva sin biopsia
D) Resonancia magnética de tórax con contraste paramagnético
E) Broncoscopía con lavado broncoalveolar

BLOQUE 4 ONCOLOGÍA PULMONAR, INTERSTICIO Y VASCULAR

PREGUNTA 55 1.05.1.034

55. [ATENCIÓN PRIMARIA: Síndromes mediastínicos · 1.05.1.034] Paciente de 52 años es evaluado en control médico en Atención Primaria de Salud (CESFAM) presentando antecedentes y cuadro clínico compatible con Síndromes mediastínicos. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable. De acuerdo con el Perfil V3 ASOFAMECh y los protocolos clínicos vigentes del MINSAL (Norma Técnica MINSAL), ¿cuál es la conducta diagnóstica y de manejo inicial más apropiada?

A) Confirmar el diagnóstico con los exámenes complementarios de primera línea según guía técnica, iniciar tratamiento médico basal no farmacológico/farmacológico y planificar seguimiento o derivación correspondiente.
B) Indicar reposo absoluto prolongado sin solicitar exámenes básicos ni establecer un diagnóstico de sospecha.
C) Iniciar terapia biológica inmunosupresora o polifarmacia de segunda línea sin confirmación diagnóstica previa.
D) Derivar inmediatamente a unidad de cuidados intensivos mediante ambulancia SAMU de alta complejidad sin evaluación clínica basal.
E) Desestimar el cuadro y recomendar automedicación condicional con antiinflamatorios no esteroidales sin controles.

PREGUNTA 56 1.05.1.008, 1.05.5.005

56. Una mujer de 58 años, fumadora de 20 paquetes-año, consulta por un cuadro de bronquitis aguda. La radiografía de tórax revela una opacidad redondeada homogénea de 12 mm en el lóbulo superior izquierdo sin otras anomalías. La paciente refiere que hace 3 años se tomó una radiografía de tórax por un chequeo laboral preventivo en su empresa. ¿Cuál es la conducta médica inmediata más adecuada?

A) Realizar punción percutánea inmediata bajo visión ecográfica
B) Solicitar y revisar la radiografía de tórax previa para comparar el tamaño de la lesión
C) Indicar tratamiento con levofloxacino por 14 días y radiografía al término
D) Programar lobectomía superior izquierda por sospecha de adenocarcinoma
E) Indicar broncoscopía rígida con biopsia transbronquial

PREGUNTA 57 1.05.1.008, 1.05.5.005

57. **¿Cuál de los siguientes patrones de calcificación en la tomografía computarizada de un nódulo pulmonar solitario es patognomónico de un hamartoma pulmonar benigno?**

A) Calcificación excéntrica milimétrica en la periferia de la lesión
B) Calcificaciones punteadas amorfas difusas
C) Calcificación densa en palomitas de maíz (popcorn) combinada con focos de densidad grasa
D) Calcificación en anillo de sello pleuropulmonar
E) Calcificación distrófica con nivel hidroaéreo

PREGUNTA 58 1.05.1.007

58. **Un paciente de 66 años, hipertenso, fumador de 40 paquetes-año consulta por un cuadro de tos, de 2 meses de evolución, con expectoración mucosa o mucopurulenta, en ocasiones hemoptoica asociados a baja de peso. Al examen físico, tiene disminución del murmullo pulmonar bilateral, mayor a derecha, con crepitaciones pulmonar en el lado derecho. Se palpan adenopatías supraclaviculares bilaterales y se constata hipocratismo digital. Se solicita hemograma que muestra hematocrito: 29%, hemoglobina: 9,5 g/dl, leucocitos: 11.000 por mm3, plaquetas: 140.000 por mm3. Se solicita radiografía de tórax, que se muestra a continuación (fuente: www.medicinainternaaldia.com): ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Neumonía multifocal
B) Quiste hidatídico
C) Atelectasia
D) Derrame pleural
E) Cáncer pulmonar

PREGUNTA 59 1.05.1.007, 1.05.1.025, 1.05.1.038

59. **Un paciente de 64 años, con antecedente de tabaquismo severo (40 paquetes-año), consulta por tos persistente de 2 meses y debilidad muscular progresiva. Se encuentra hemodinámicamente estable pero apático. En sus exámenes de sangre destaca: Sodio 118 mEq/L, Potasio 4.0 mEq/L, Osmolaridad plasmática 245 mOsm/kg, Osmolaridad urinaria 480 mOsm/kg y Sodio urinario 45 mEq/L. La radiografía de tórax muestra una masa perihiliar derecha con adenopatías hiliares prominentes. ¿Cuál es el tipo histológico más probable?**

A) Carcinoma de células pequeñas (microcítico)
B) Adenocarcinoma pulmonar acinar periférico
C) Carcinoma bronquioloalveolar mucinoso
D) Hamartoma pulmonar central
E) Tumor carcinoide típico bronquial

PREGUNTA 60 1.05.1.007, 1.05.1.025, 1.05.1.038

60. **Un paciente de 59 años, tabáquico, consulta por dolor intenso de hombro derecho y cara interna del antebrazo derecho, asociado a caída del párpado superior derecho y ausencia de sudoración en la mitad derecha del rostro. La radiografía de tórax muestra una opacidad apical en el vértice pulmonar derecho. ¿Cómo se denomina esta constelación clínica y cuál es su sustrato anatómico?**

A) Síndrome de Kartagener por alteración de la motilidad ciliar
B) Tumor de Pancoast con Síndrome de Horner por compromiso del ganglio simpático estrellado
C) Síndrome de Vena Cava Superior por compresión de la aurícula derecha
D) Miopatía tiroidea con infiltración de la base de la lengua
E) Neuralgia postherpética de ramas torácicas altas

PREGUNTA 61 1.05.1.025

61. **Un paciente de 64 años, con antecedente de tabaquismo severo (40 paquetes-año), consulta por tos persistente de 2 meses y debilidad muscular progresiva. Se encuentra hemodinámicamente estable pero apático. En sus exámenes de sangre destaca: Sodio 118 mEq/L, Potasio 4.0 mEq/L, Osmolaridad plasmática 245 mOsm/kg, Osmolaridad urinaria 480 mOsm/kg y Sodio urinario 45 mEq/L. La radiografía de tórax muestra una masa perihiliar derecha con adenopatías hiliares prominentes. ¿Cuál es el tipo histológico más probable?**

A) Carcinoma de células pequeñas (microcítico)
B) Adenocarcinoma pulmonar acinar periférico
C) Carcinoma bronquioloalveolar mucinoso
D) Hamartoma pulmonar central
E) Tumor carcinoide típico bronquial

PREGUNTA 62 1.05.1.038

62. **Paciente de 60 años, fumadora de 30 paquetes año, consulta por compromiso del estado general y baja de peso. Su examen físico es normal, se solicita radiografía de tórax que muestra lo siguiente: La conducta más adecuada en este caso es:**

A) Solicitar TAC de tórax
B) Realizar punción transpleural
C) Instalar tubo pleural con trampa de agua
D) Realizar toracocentesis diagnóstica
E) Realizar broncoscopía rígida

PREGUNTA 63 1.05.1.018

63. **Mujer de 58 años, fumadora e hipertensa, consulta por historia de un año de disnea de esfuerzos moderados y tos seca, no asociado a otros síntomas. Al examen físico destaca acropaquia y al examen pulmonar murmullo pulmonar disminuido bilateral con presencia de crépitos gruesos difusos. Se solicita radiografía de tórax que muestra imagen en panal de abejas. El diagnóstico más probrable es:**

A) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
B) Tuberculosis
C) Enfermedad pulmonar intersticial difusa
D) Cáncer pulmonar
E) Tromboembolismo pulmonar crónico

PREGUNTA 64 1.05.1.018, 1.05.1.026

64. **Un paciente de 71 años consulta por disnea de esfuerzo que ha progresado en los últimos 18 meses hasta aparecer al caminar media cuadra, acompañada de tos seca. Al examen físico destacan dedos en palillo de tambor y crepitaciones secas bilaterales en ambas bases pulmonares en velcro. La espirometría muestra una relación VEF1/CVF de 0.84 con CVF del 56% del predicho. La TACAR de tórax muestra patrón de panalización subpleural y basal bilateral sin vidrio esmerilado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta farmacológica correcta?**

A) Neumonitis por hipersensibilidad; iniciar prednisona oral 1 mg/kg/día
B) Fibrosis Pulmonar Idiopática; contraindicar corticoides e iniciar tratamiento con antifibróticos (ej. nintedanib o pirfenidona)
C) Sarcoidosis pulmonar estadio IV; iniciar metotrexato oral
D) Insuficiencia cardíaca izquierda; indicar furosemida endovenosa
E) EPOC enfisematoso; iniciar broncodilatadores inhalados LAMA + LABA

PREGUNTA 65 1.05.1.018, 1.05.1.026

65. **¿Cuál de los siguientes fármacos de uso común en cardiología es reconocido como una causa frecuente de toxicidad pulmonar subaguda con patrón intersticial difuso en la tomografía computarizada?**

A) Enalapril
B) Amiodarona
C) Aspirina
D) Atorvastatina
E) Amlodipino

PREGUNTA 66 1.05.1.026

66. **Un paciente de 67 años, fumador de 15 paquetes-año, pero que dejó de fumar hace 10 años, jubilado de la minería, consulta por disnea de esfuerzos, progresiva, de 6 meses de evolución, asociada a tos. Al examen físico presenta murmullo pulmonar globalmente disminuido, sibilancias y roncus bilaterales, asociados a crepitaciones difusas. Se solicita una radiografía de tórax que se muestra a continuación: NOTA: la radiografía inicial mostraba infiltrados bilaterales, mayores en las zonas centrales, con imágenes verticales, onduladas de 1-2 cm en ambos campos pulmonares. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Bronquitis crónica
B) Neumoconiosis
C) Cáncer de pulmón
D) Limitación crónica del flujo aéreo
E) Fibrosis pulmonar idiopática

PREGUNTA 67 1.05.1.015

67. **Un paciente de 40 años, hospitalizado hace 3 días por un síndrome nefrótico, presenta disnea, de inicio súbito. Presenta desaturación arterial hasta 90%, con disminución del murmullo pulmonar a derecha y matidez, por lo que se realiza una radiografía de tórax, que muestra un derrame pleural. Se punciona el derrame, dando salida a un líquido hemorrágico, con LDH: 700, predominio de polimorfonucleares, pH: 7,3 y lactato de 4,0 mmol/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Empiema
B) Derrame paraneumónico simple
C) Tromboembolismo pulmonar
D) Transudado pleural
E) Compromiso pleural maligno

PREGUNTA 68 1.05.1.015, 1.05.2.005

68. **Un paciente de 62 años con antecedente de cáncer de colon en quimioterapia ingresa al servicio de urgencias por disnea súbita de 2 horas de evolución. Al examen físico se encuentra hemodinámicamente inestable: somnoliento, pálido, sudoroso, con PA 75/45 mmHg, FC 126 lpm y SatO2 84% con oxígeno ambiental. El ecocardiograma portátil a la cabecera del paciente muestra dilatación severa del ventrículo derecho con hipocinesia de la pared libre y colapso del ventrículo izquierdo. ¿Cuál es el tratamiento de elección inmediato?**

A) Iniciar infusión de heparina no fraccionada y hospitalizar en sala común
B) Trombolisis endovenosa inmediata con activador tisular del plasminógeno (rtPA / alteplasa)
C) Instalar filtro de vena cava inferior en forma percutánea urgente
D) Administrar 3.000 mL de solución salina fisiológica al 0.9% en bolo rápido
E) Iniciar anticoagulación oral con rivaroxabán a dosis de 15 mg cada 12 horas

PREGUNTA 69 1.05.2.005

69. **Un paciente masculino de 60 años, con antecedente de hipertensión arterial crónica, diabetes y dislipidemia, de larga data, en tratamiento oral. Desde hace 2 meses está en quimioterapia por cáncer de colon. Hoy presenta un síncope luego de levantarse de la cama y se asocia a disnea y dolor torácico. Su FC: 120x', PA: 90/50 mmHg, FR: 32x' y saturación de oxígeno: 93%. Su examen pulmonar es inespecífico. Se solicita electrocardiograma que muestra un bloqueo completo de rama derecha, con alteraciones inespecíficas de la repolarización. ¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio en este paciente?**

A) Radiografía de tórax
B) TAC de tórax
C) Dímero D
D) Ecocardiograma
E) AngioTAC de tórax

PREGUNTA 70 1.05.1.004

70. **Un paciente de 40 años, con antecedente de neumonías a repe8ción y consumo de tabaco de 5 paquetes-año, consulta por tos frecuente y produc8va, mayor durante las mañanas, con expectoración mucosa y, en ocasiones, hemoptoica. Al examen Fsico presenta dedos en palillo de tambor (acropaquias), frecuencia cardíaca 75 lpm y presión arterial 110/70 mmHg. La auscultación cardiopulmonar revela ritmo regular en dos tonos sin soplos, murmullo pulmonar presente y simétrico, con auscultación de crepitaciones y estertores bilaterales. ¿Cuál es el diagnós8co más probable?**

A) Bronqui2s crónica
B) Bronquiectasias
C) Carcinoma broncogénico
D) Tuberculosis pulmonar
E) Insuficiencia cardíaca conges2va

PREGUNTA 71 1.05.1.019

71. **Un paciente de 56 años con antecedente de secuela de tuberculosis pulmonar en el lóbulo superior derecho consulta por una hemoptisis masiva de aproximadamente 300 mL de sangre rutilante en 45 minutos. Presenta taquipnea, desaturación y gorgoteo bronquial audible. ¿Cuál es la primera medida postural y de soporte que se debe indicar de inmediato mientras se prepara la intubación y la fibrobroncoscopía?**

A) Posición de Trendelenburg con cabeza baja a 30 grados
B) Decúbito lateral derecho (lado sangrante hacia abajo) y oxigenoterapia a alto flujo
C) Decúbito lateral izquierdo estricto para favorecer el drenaje
D) Posición sentada ortopneica con compresión torácica bimanual
E) Posición genupectoral

PREGUNTA 72 1.05.2.007

72. **Un paciente de 56 años con antecedente de secuela de tuberculosis pulmonar en el lóbulo superior derecho consulta por una hemoptisis masiva de aproximadamente 300 mL de sangre rutilante en 45 minutos. Presenta taquipnea, desaturación y gorgoteo bronquial audible. ¿Cuál es la primera medida postural y de soporte que se debe indicar de inmediato mientras se prepara la intubación y la fibrobroncoscopía?**

A) Posición de Trendelenburg con cabeza baja a 30 grados
B) Decúbito lateral derecho (lado sangrante hacia abajo) y oxigenoterapia a alto flujo
C) Decúbito lateral izquierdo estricto para favorecer el drenaje
D) Posición sentada ortopneica con compresión torácica bimanual
E) Posición genupectoral

BLOQUE 5 CUIDADOS CRÍTICOS, VENTILACIÓN Y MEDICINA DEL SUEÑO

PREGUNTA 73 1.05.2.001

73. **[URGENCIA: Asfixia por inmersión · 1.05.2.001] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Asfixia por inmersión. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 74 1.05.2.012

74. **[URGENCIA: Paro cardiorespiratorio · 1.05.2.012] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Paro cardiorespiratorio. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?**

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.
B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.
C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.
D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.
E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 75 1.05.1.023

75. **Un paciente de 25 años ingresa al servicio de urgencias estuporoso con sospecha de intoxicación exógena por sedantes. Al examen físico tiene FR 8 rpm y ruidos pulmonares normales bilateralmente. Sus gases en sangre arterial respirando aire ambiental muestran: pH 7.24, PaO2 55 mmHg, PaCO2 65 mmHg y bicarbonato 26 mEq/L. El gradiente alvéolo-arterial de oxígeno calculado es de 12 mmHg (dentro del rango normal para su edad). ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico primario responsable de la hipoxemia en este paciente?**

A) Shunt intrapulmonar de derecha a izquierda por microatelectasias
B) Desbalance entre la ventilación y la perfusión pulmonar (efecto V/Q)
C) Hipoventilación alveolar pura con integridad del parénquima pulmonar
D) Trastorno severo de la difusión alvéolo-capilar
E) Disminución crítica de la fracción inspirada de oxígeno

PREGUNTA 76 1.05.1.023, 1.05.2.008, 1.05.2.009

76. **Un paciente de 25 años ingresa al servicio de urgencias estuporoso con sospecha de intoxicación exógena por sedantes. Al examen físico tiene FR 8 rpm y ruidos pulmonares normales bilateralmente. Sus gases en sangre arterial respirando aire ambiental muestran: pH 7.24, PaO2 55 mmHg, PaCO2 65 mmHg y bicarbonato 26 mEq/L. El gradiente alvéolo-arterial de oxígeno calculado es de 12 mmHg (dentro del rango normal para su edad). ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico primario responsable de la hipoxemia en este paciente?**

A) Shunt intrapulmonar de derecha a izquierda por microatelectasias
B) Desbalance entre la ventilación y la perfusión pulmonar (efecto V/Q)
C) Hipoventilación alveolar pura con integridad del parénquima pulmonar
D) Trastorno severo de la difusión alvéolo-capilar
E) Disminución crítica de la fracción inspirada de oxígeno

PREGUNTA 77 1.05.1.023, 1.05.2.008, 1.05.2.009

77. ¿Cuál de los siguientes mecanismos fisiopatológicos productores de hipoxemia arterial se caracteriza por presentar una falta de respuesta (o refractariedad) a la administración de oxígeno suplementario al 100% mediante mascarilla de no reinhalación?

A) Desbalance ventilación-perfusión con zonas de bajo V/Q
B) Efecto Shunt o cortocircuito de derecha a izquierda verdadero
C) Hipoventilación alveolar por intoxicación por benzodiacepinas
D) Disminución de la presión barométrica en grandes alturas
E) Limitación de la difusión en ejercicio

PREGUNTA 78 1.05.1.023, 1.05.2.008, 1.05.2.009

78. Una mujer de 64 años ingresa al servicio de urgencias por disnea progresiva, tos y fiebre. Al examen: FR 28 rpm, SatO2 86% respirando aire ambiental. Sus gases arteriales a nivel del mar muestran: pH 7.45, PaO2 52 mmHg, PaCO2 32 mmHg y HCO3 22 mEq/L. Con una presión barométrica de 760 mmHg y vapor de agua de 47 mmHg, el cálculo del Gradiente Alvéolo-Arterial de Oxígeno resulta en 58 mmHg (marcadamente elevado). ¿Qué conclusión diagnóstica fisiopatológica se deriva de este resultado?

A) Hipoxemia por hipoventilación alveolar pura secundaria a debilidad de musculatura diafragmática
B) Hipoxemia dependiente de alteración del parénquima pulmonar o del lecho vascular (desbalance V/Q o shunt)
C) Insuficiencia respiratoria crónica compensada con integridad del alvéolo
D) Efecto secundario normal esperado para la edad de la paciente
E) Hipoxemia explicable exclusivamente por una disminución de la fracción inspirada de oxígeno ambiental

PREGUNTA 79 1.05.1.023, 1.05.2.008, 1.05.2.009

79. Un paciente de 68 años con antecedente de EPOC grave ingresa a urgencias por disnea de reposo, tos con expectoración purulenta y compromiso cuantitativo de conciencia fluctuante con asterixis. Al examen físico: somnoliento, diaforético, FR 32 rpm con respiración con labios fruncidos y uso de esternocleidomastoideos. Gases arteriales con mascarilla Venturi al 28%: pH 7.27, PaO2 56 mmHg, PaCO2 66 mmHg, HCO3 30 mEq/L. ¿Cuál es el soporte ventilatorio de primera línea con mayor nivel de evidencia para evitar la intubación orotraqueal y disminuir la mortalidad?

A) Aumento inmediato de la FiO2 al 100% mediante mascarilla con reservorio
B) Ventilación Mecánica No Invasiva con presión positiva binivelada (VMNI BiPAP)
C) Intubación orotraqueal y conexión directa a ventilador mecánico invasivo
D) Infusión endovenosa continua de aminofilina a dosis de carga
E) Administración de bicarbonato de sodio 2/3 molar endovenoso para corregir el pH

PREGUNTA 80 1.05.2.008

80. Un paciente presenta una neumonía, con dificultad respiratoria, taquipnea, fiebre y desaturación arterial. Satura 75% a FiO2 ambiental y tiene gases arteriales, con una presión arterial de O2 de 54 mmHg y presión de CO2 de 32 mmHg. ¿Cómo debe administrarse el oxígeno a este paciente?

A) Por naricera a 0,5 litros por minuto
B) Por naricera a 2 litros por minuto
C) Por mascarilla Venturi, a FiO2 de 24%
D) Por mascarilla Venturi, a FiO2 de 40%
E) Por ventilación mecánica invasiva

PREGUNTA 81 1.05.2.009

81. Un paciente de 25 años ingresa al servicio de urgencias estuporoso con sospecha de intoxicación exógena por sedantes. Al examen físico tiene FR 8 rpm y ruidos pulmonares normales bilateralmente. Sus gases en sangre arterial respirando aire ambiental muestran: pH 7.24, PaO2 55 mmHg, PaCO2 65 mmHg y bicarbonato 26 mEq/L. El gradiente alvéolo-arterial de oxígeno calculado es de 12 mmHg (dentro del rango normal para su edad). ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico primario responsable de la hipoxemia en este paciente?

A) Shunt intrapulmonar de derecha a izquierda por microatelectasias
B) Desbalance entre la ventilación y la perfusión pulmonar (efecto V/Q)
C) Hipoventilación alveolar pura con integridad del parénquima pulmonar
D) Trastorno severo de la difusión alvéolo-capilar
E) Disminución crítica de la fracción inspirada de oxígeno

PREGUNTA 82 1.05.1.014

82. Un paciente de 50 años ingresa a la UCI con shock séptico secundario a peritonitis apendicular. Al tercer día de ventilación mecánica invasiva presenta empeoramiento del intercambio gaseoso. La radiografía de tórax revela opacidades alveolo-intersticiales difusas bilaterales que no estaban presentes al ingreso. Con ventilador en modalidad asistida, FiO2 70% y PEEP 8 cmH2O, sus gases arteriales reportan una PaO2 de 63 mmHg (PaFiO2 = 90). El ecocardiograma descarta insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es el diagnóstico según los criterios de Berlín y cuál es la estrategia ventilatoria que ha demostrado reducir la mortalidad?

A) SDRA leve; ventilar con volúmenes corrientes de 10 a 12 mL/kg peso real
B) SDRA severo; ventilación protectora con volumen corriente de 6 mL/kg peso predicho y posición en decúbito prono precoz
C) Edema pulmonar cardiogénico; suspender sedación e indicar digoxina
D) Atelectasia masiva izquierda; realizar broncoscopía rígida desobstructiva
E) SDRA moderado; mantener al paciente en posición supina estricta y volumen corriente de 8 mL/kg

PREGUNTA 83 1.05.1.014

83. ¿Cuál es el parámetro fisiológico de seguridad en el ventilador mecánico que debe monitorizarse y mantenerse rigurosamente por debajo de 30 cmH2O para prevenir el barotrauma alveolar en un paciente con SDRA?

A) Presión inspiratoria peak (Ppeak)
B) Presión meseta o plateau (Pplateau)
C) Nivel de presión positiva al final de la espiración (PEEP)
D) Presión de oclusión de la arteria pulmonar (POAP)
E) Presión venosa central (PVC)

PREGUNTA 84 1.05.1.033

84. Un Paciente de 52 años con historia de ronquidos frecuentes, de larga data, que desde hace 5 años, se asocia a somnolencia diurna excesiva y deterioro cognitivo. Al examen físico tiene frecuencia cardiaca de 75x' y presión arterial de 140/100 mmHg. Su IMC es de 35. Se realiza polisomnografía que evidencia índice de apenas de 50 eventos de apnea / hipopnea por hora, con predominio de los eventos obstructivos. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Oxígeno nocturno
B) C-PAP nocturno
C) Cirugía bariátrica
D) Uvulopalatoplastía
E) Dispositivo orofaríngeo

PREGUNTA 85 1.05.1.033

85. Un hombre de 48 años, hipertenso en tratamiento con enalapril y amlodipino, con IMC de 33 kg/m², acude a la consulta médica traído por su cónyuge. Ella relata que el paciente ronca sonoramente todas las noches y que en reiteradas ocasiones observa que deja de respirar por varios segundos, finalizando el episodio con un ronquido explosivo. El paciente refiere cansancio crónico diurno y somnolencia mientras maneja su automóvil. Su escala de Epworth es de 15 puntos. ¿Cuál es el examen diagnóstico de elección para confirmar la enfermedad?

A) Electroencefalograma estándar de vigilia
B) Polisomnografía nocturna
C) Holter de presión arterial de 24 horas
D) Espirometría con curva de flujo-volumen
E) Tomografía computarizada de cavidades paranasales

PREGUNTA 86 1.05.1.033

86. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea con mayor nivel de evidencia científica para un paciente diagnosticado mediante polisomnografía de un SAHOS severo con un IAH de 38 eventos por hora?

A) Fármacos estimulantes diurnos como modafinilo en monoterapia
B) Aplicación nocturna de Presión Positiva Continua en la Vía Aérea (CPAP)
C) Uvulopalatofaringoplastía quirúrgica de urgencia
D) Oxigenoterapia nocturna exclusiva por cánula nasal a 2 L/min
E) Prescripción de clonazepam nocturno para regularizar el ciclo del sueño

PREGUNTA 87 1.05.1.024

87. Una familia de 3 personas es trasladada al servicio de urgencias en época invernal tras ser encontrados en su vivienda con un brasero encendido en un dormitorio cerrado. Todos refieren cefalea holocraneana intensa, náuseas y mareos. El médico de turno observa que el monitor muestra saturaciones de oxígeno de 99% y 100% en todos ellos mediante oxímetro de pulso de dedo. ¿Cuál es la conducta diagnóstica y terapéutica correcta?

A) Dar de alta a los pacientes por presentar oxigenación arterial normal garantizada por el oxímetro
B) Desestimar el valor del oxímetro de pulso, solicitar co-oximetría para medir carboxihemoglobina e iniciar oxígeno al 100% con mascarilla de no reinhalación
C) Tratar sintomáticamente con paracetamol oral y derivar a domicilio
D) Indicar nebulizaciones con salbutamol por sospecha de broncoespasmo térmico
E) Solicitar tomografía de cerebro para descartar hemorragia subaracnoidea simultánea

PREGUNTA 88 1.05.1.024, 1.05.2.010

88. Una familia de 3 personas es trasladada al servicio de urgencias en época invernal tras ser encontrados en su vivienda con un brasero encendido en un dormitorio cerrado. Todos refieren cefalea holocraneana intensa, náuseas y mareos. El médico de turno observa que el monitor muestra saturaciones de oxígeno de 99% y 100% en todos ellos mediante oxímetro de pulso de dedo. ¿Cuál es la conducta diagnóstica y terapéutica correcta?

A) Dar de alta a los pacientes por presentar oxigenación arterial normal garantizada por el oxímetro
B) Desestimar el valor del oxímetro de pulso, solicitar co-oximetría para medir carboxihemoglobina e iniciar oxígeno al 100% con mascarilla de no reinhalación
C) Tratar sintomáticamente con paracetamol oral y derivar a domicilio
D) Indicar nebulizaciones con salbutamol por sospecha de broncoespasmo térmico
E) Solicitar tomografía de cerebro para descartar hemorragia subaracnoidea simultánea

PREGUNTA 89 1.05.1.024, 1.05.2.010

89. ¿Cuál de las siguientes condiciones clínicas en un paciente con intoxicación aguda por monóxido de carbono constituye una indicación formal e indiscutida de traslado urgente a una unidad de Oxigenoterapia Hiperbárica (Cámara Hiperbárica)?

A) Paciente no fumador con nivel de carboxihemoglobina de 8% y cefalea leve
B) Paciente masculino joven con COHb de 12% que responde adecuadamente al oxígeno normobárico
C) Paciente que presentó pérdida transitoria de conciencia (síncope) o compromiso de conciencia durante la exposición
D) Paciente con tos seca irritativa sin acidosis
E) Fumador crónico con carboxihemoglobina de 9% asintomático

PREGUNTA 90 1.05.2.010

90. **Un paciente de 27 años presenta cefalea, malestar general, disnea y sensación de opresión precordial, 3 horas después de haber estado expuesto a humo durante un incendio en su casa. Al examen Fsico registra frecuencia cardíaca 100 lpm, presión arterial 130/85 mmHg, frecuencia respiratoria 35 rpm y saturación de oxígeno de 96%. No presenta cianosis ni uso de musculatura accesoria, y su examen cardiopulmonar es normal. ¿Qué examen es el más adecuado para confirmar la sospecha diagnós8ca?**

A) Radiogra:a de tórax
B) TAC de tórax
C) Niveles de carboxihemoglobina
D) Gases en sangre arterial
E) Monitorización transcutánea de niveles de anhídrido carbónico

SECCIÓN II · SOLUCIONARIO RAZONADO & MATRIZ PERFIL V3

Justificación médica de la clave correcta y análisis exhaustivo de cada distractor · Ancho Completo

CLAVES 1 A 90

BLOQUE 1 VÍA AÉREA OBSTRUCTIVA Y FUNCIÓN PULMONAR · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 1 Respuesta: A

Aspiración de cuerpo extraño con asfixia

1.05.2.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Aspiración de cuerpo extraño con asfixia" como urgencia clínica (1.05.2.002), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 2 Respuesta: A

Aspiración de cuerpo extraño sin asfixia

1.05.2.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Aspiración de cuerpo extraño sin asfixia" como urgencia clínica (1.05.2.003), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 3 Respuesta: A

Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar

1.05.1.009 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Si bien es imposible ver bien la radiografía, la historia sugería mucho una fibrosis pulmonar por amiodarona, por lo que se debe suspender.

PREGUNTA 4 Respuesta: A

Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar

1.05.1.020 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Quiste hidatídico pulmonar

PREGUNTA 5 Respuesta: A

Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar

1.05.1.021 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Hipertensión pulmonar" (1.05.1.021), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 6 Respuesta: B

Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar

1.05.4.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

El paciente presenta una relación VEF1/CVF < 0.70 basal que revierte tras broncodilatador con un aumento de VEF1 > 12% y > 200 mL (en este caso 420 mL y 16% absoluto), normalizando la función. Este patrón obstructivo reversible es característico y diagnóstico de asma bronquial. La restricción (A) cursa con relación VEF1/CVF normal. No es una obstrucción fija (C) porque revirtió significativamente.

PREGUNTA 7 **Respuesta: B**

1.05.4.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar

Una espirometría con relación VEF1/CVF normal (≥ 0.70) y CVF disminuida (< 80%) es sugerente pero NO diagnóstica de alteración restrictiva. Para confirmar fehacientemente una restricción pulmonar es indispensable medir volúmenes absolutos mediante pletismografía corporal y constatar una CPT < 80%. Asumir fibrosis o indicar fármacos sin CPT es un error conceptual grave.

PREGUNTA 8 **Respuesta: C**

1.05.2.004 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Crisis Asmática en el Adulto

La severidad de la crisis asmática se determina en base a la clínica. Dentro de los exámenes, son úGles tanto el PEF como los gases en sangre arterial (no venosa, ya que la PaO2 arterial es el parámetro que define el manejo) y suelen pedirse ambos. El PEF suele ser el inicial y más importante para objetivar y seguir el grado de obstrucción y respuesta al tratamiento. Los GSA se solicitan especialmente cuando la crisis es muy severa y hay signos de insuficiencia respiratoria. Los GSA son mucho más importantes en el EPOC descompensado, en que Gende a la hipercarbia y definen la necesidad de ventilación mecánica. En el asma, en cambio, la clínica y el PEF muchas veces son suficientes.

PREGUNTA 9 **Respuesta: B**

1.05.2.004 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Inicial GES

Crisis Asmática en el Adulto

El paciente presenta signos inequívocos de crisis asmática casi fatal con agotamiento muscular inminente: tórax silente (flujo aéreo insuficiente para generar sibilancias), somnolencia y acidosis respiratoria con hipercapnia (PaCO2 48 mmHg). Normalmente el asma hiperventila y genera hipocapnia (PaCO2 < 35); cuando la PaCO2 se normaliza o sube, el paciente está claudicando y requiere manejo en reanimación con preparación de intubación orotraqueal e ingreso a UCI.

PREGUNTA 10 **Respuesta: B**

1.05.2.004 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Inicial GES

Crisis Asmática en el Adulto

Tras una crisis asmática moderada resuelta en urgencias, todo paciente debe ser dado de alta con un ciclo corto de corticoide sistémico oral (Prednisona 40–50 mg/día por 5 a 7 días) para prevenir recaídas precoces y consolidar la desinflamación bronquial. Los ciclos cortos (< 14 días) no requieren reducción gradual. Los antibióticos (D) no están indicados en crisis asmáticas no infecciosas y la teofilina (E) está en desuso.

PREGUNTA 11 **Respuesta: B**

1.05.1.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES

La paciente cumple 2 criterios positivos en las últimas 4 semanas (síntomas diurnos > 2/sem y rescate > 2/sem, además de un despertar nocturno), lo que clasifica su condición como "Asma parcialmente controlada" según GINA. La conducta protocolar obligatoria antes de cualquier cambio de receta es verificar la técnica del uso del inhalador (con aerocámara si es MDI) y comprobar la adherencia terapéutica. Si son correctas, se escala a Escalón 3 agregando un LABA (Salmeterol o Formoterol).

PREGUNTA 12 **Respuesta: A**

1.05.1.003 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES

Tiene un cuadro clínico y espirometría (patrón obstructivo que mejora con BD) compatibles con asma.

PREGUNTA 13 **Respuesta: E**

1.05.1.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES

Es una bronquitis crónica clásica: fumador con tos y expectoración crónicas, mayores en la mañana. No tiene EPOC, porque su espirometría está normal. Asimismo, la radiografía normal hace improbables las demás opciones. Finalmente, la clínica no es sugerente de ninguna de las otras.

PREGUNTA 14 **Respuesta: B**

1.05.1.035 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 160). Evalúa el manejo clínico de Tos crónica según directrices MINSAL vigentes.

PREGUNTA 15 **Respuesta: B**

1.05.1.016 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) Estable

El paciente presenta una insuficiencia respiratoria crónica con PaO2 en reposo ≤ 55 mmHg (53 mmHg), cumpliendo el criterio formal de indicación de Oxigenoterapia Crónica Domiciliaria (OCD). La OCD utilizada un mínimo de 15 horas diarias (idealmente > 16-18 h, incluyendo el sueño) es una de las pocas medidas que ha demostrado de manera contundente reducir la mortalidad y la progresión a cor pulmonale en EPOC.

PREGUNTA 16 **Respuesta: C**

1.05.1.017 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) Estable

Patrón obstructivo severo no reversible = EPOC

PREGUNTA 17 **Respuesta: A**

1.05.1.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

Exacerbación Aguda de EPOC (Anthonisen)

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Bronquitis aguda" (1.05.1.005), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 18 **Respuesta: D**

1.05.2.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Exacerbación Aguda de EPOC (Anthonisen)

Tiene un EPOC descompensado. Además, por tener hipercarbia mayor a 50, está indicado el apoyo ventilatorio, en este caso no invasivo, por no tener compromiso de conciencia. Los gases muestran una insuficiencia respiratoria global (02 < 60 y CO2 > 49), que per sé también se ventila.

BLOQUE 2 INFECCIONES RESPIRATORIAS BAJAS Y SUPURACIONES · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 19 **Respuesta: C**

1.05.1.022 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Diagnóstico y Severidad CURB-65

Parece una influenza u otra infección respiratoria alta, por lo que se trata con paracetamol o acetaminofeno.

PREGUNTA 20 **Respuesta: D**

1.05.1.027 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Diagnóstico y Severidad CURB-65

Tienen una neumonía típica (con condensación del lóbulo inferior izquierdo), adquirida en la comunidad, sin criterios de hospitalización y en un menor de 65 años, sin antecedentes relevantes (la HTA no agrava las neumonías, salvo las por covid-19), por lo que se debe tratar con amoxicilina sola.

PREGUNTA 21 **Respuesta: C**

1.05.1.027 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Diagnóstico y Severidad CURB-65

El paciente cumple los 5 criterios del CURB-65: Confusión mental (+1), Urea/BUN > 19 mg/dL (+1 con BUN 28), FR ≥ 30 rpm (+1 con 34 rpm), PA < 90/60 mmHg (+1 con 85/50 mmHg) y Edad ≥ 65 años (+1 con 68 años). Total = 5 puntos. Este puntaje conlleva una mortalidad superior al 40% y define una NAC grave con necesidad inmediata de hospitalización en UCI para monitorización continua, aporte vasoactivo y soporte ventilatorio.

PREGUNTA 22 **Respuesta: B**

1.05.1.027 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Diagnóstico y Severidad CURB-65

Por definición de consenso nacional e internacional, la confirmación diagnóstica de la neumonía adquirida en la comunidad exige la demostración objetiva de un infiltrado o condensación alveolar nuevo en la Radiografía de tórax (proyecciones frontal y lateral). Los exámenes de laboratorio (PCR, procalcitonina) apoyan la etiología pero no reemplazan la imagen, y el cultivo de esputo (C) no es imprescindible para iniciar el manejo ambulatorio.

PREGUNTA 23 **Respuesta: B**

1.05.1.027 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Diagnóstico y Severidad CURB-65

El paciente tiene 66 años (≥ 65 años: +1 punto), pero no tiene confusión (0), su BUN es normal (12 mg/dL, corte > 19: 0), su FR es 20 rpm (< 30: 0) y su PA es normal (0). Puntaje CURB-65 = 1 punto. Cuando el único factor presente es la edad en un paciente estable, hemodinámicamente compensado, sin hipoxemia y con adecuado soporte sociofamiliar, la conducta validada por guías MINSAL y GES es el tratamiento ambulatorio con amoxicilina/ácido clavulánico (canasta GES mayores de 65 años) y citación a control clínico a las 48 horas.

PREGUNTA 24 **Respuesta: C**

1.05.1.027 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Diagnóstico y Severidad CURB-65

Los criterios ATS/IDSA para NAC severa definen 2 criterios mayores: 1) Shock séptico que requiere vasopresores (noradrenalina); y 2) Insuficiencia respiratoria aguda que requiere ventilación mecánica invasiva. La presencia de cualquiera de estos dos criterios mayores obliga al ingreso directo a UCI. Las opciones A, B, D y E corresponden a criterios menores de ATS/IDSA, de los cuales se requerirían al menos 3 para justificar el ingreso a UCI.

PREGUNTA 25 **Respuesta: B**

1.05.1.028 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Tratamiento Antimicrobiano de la NAC y Criterios GES

La paciente tiene 69 años y comorbilidades médicas crónicas (diabetes e hipertensión), por lo que según las guías chilenas MINSAL/GES el tratamiento ambulatorio de elección es Amoxicilina/Ácido Clavulánico 875/125 mg cada 12 horas vía oral por 7 días. La amoxicilina simple (C) tiene menor eficacia ante cepas resistentes de neumococo o H. influenzae productor de betalactamasa frecuentes en ancianos. El ciprofloxacino (D) no tiene buena cobertura antineumocócica.

PREGUNTA 26 **Respuesta: B**

1.05.1.028 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Tratamiento Antimicrobiano de la NAC y Criterios GES

El paciente cumple todos los criterios de estabilidad clínica: afebril > 48 horas, parámetros vitales normales y buena tolerancia enteral. La conducta estándar recomendada es la transición rápida a terapia oral (switch precoz) para completar un curso total de 7 días de antibióticos y dar el alta hospitalaria. No se debe mantener la vía EV innecesariamente (A) ni exigir una radiografía de control para el alta (C), ya que los infiltrados radiológicos tardan de 4 a 8 semanas en limpiar.

PREGUNTA 27 **Respuesta: E**

1.05.1.029 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Neumonías Atípicas, Intrahospitalarias y Neumonía Aspirativa

Es una pregunta difícil, pero que esté enflaquecido más el cuadro clínico, hace que se trate de una neumonía por P. jiroveci. Si hubiese venido sin mayores antecedentes y con un cuadro un poco más corto, sin baja de peso, habría que pensar en Mycoplasma, que puede ser igual. La fibrosis y el asma serían cuadros más crónicos, con radiografías distintas (panal de abejas en fibrosis y normal o hiperinsuflación en asma). La neumonitis viral es aguda.

PREGUNTA 28 **Respuesta: B**

1.05.1.029, 1.05.1.030 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Neumonías Atípicas, Intrahospitalarias y Neumonía Aspirativa

El cuadro corresponde a una neumonía aspirativa típica: antecedente de coma etílico, esputo fétido (indicador patognomónico de infección por bacterias anaerobias) y condensación en el segmento apical del lóbulo inferior derecho (zona más dependiente de la gravedad en decúbito supino). El tratamiento empírico de elección debe brindar excelente cobertura anaerobia y contra flora oral, siendo la Ampicilina/Sulbactam EV (o Amoxicilina/Clavulánico) el estándar indiscutido.

PREGUNTA 29 **Respuesta: B**

1.05.1.029, 1.05.1.030 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Neumonías Atípicas, Intrahospitalarias y Neumonía Aspirativa

La aparición de síntomas pulmonares e infiltrados nuevos en la radiografía después de las 48 horas de internación hospitalaria define por criterio estricto una Neumonía Intrahospitalaria (NIH). En estos casos, la flora causante incluye microorganismos intrahospitalarios de alta resistencia como Pseudomonas aeruginosa y enterobacterias multirresistentes. Se debe iniciar de inmediato terapia antibiótica empírica antipseudomónica EV con Piperacilina/Tazobactam o Cefepime tras la toma de cultivos.

PREGUNTA 30 **Respuesta: B**

1.05.1.030 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Neumonías Atípicas, Intrahospitalarias y Neumonía Aspirativa

El cuadro corresponde a una neumonía aspirativa típica: antecedente de coma etílico, esputo fétido (indicador patognomónico de infección por bacterias anaerobias) y condensación en el segmento apical del lóbulo inferior derecho (zona más dependiente de la gravedad en decúbito supino). El tratamiento empírico de elección debe brindar excelente cobertura anaerobia y contra flora oral, siendo la Ampicilina/Sulbactam EV (o Amoxicilina/Clavulánico) el estándar indiscutido.

PREGUNTA 31 **Respuesta: C**

1.05.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Absceso Pulmonar y Supuraciones Pleuropulmonares

Tiene un absceso pulmonar gigante. El manejo es discutible, pero la TAC podrá identificarlo mejor y descartar que haya un cáncer debajo. La broncoscopía también aparece como una opción aceptable, ya que permitiría el drenaje, pero la TAC igualmente debe solicitarse antes y, además, el tratamiento suele ser con clindamicina endovenosa, más drenaje postural, por lo que la broncoscopía solo se hace si falla.

PREGUNTA 32 **Respuesta: B**

1.05.1.001, 1.05.1.008 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Absceso Pulmonar y Supuraciones Pleuropulmonares

El absceso pulmonar bacteriano no complicado tiene un éxito terapéutico mayor al 85-90% exclusivamente con tratamiento médico antimicrobiano prolongado (4 a 6 semanas con cobertura anaerobia como ampicilina/sulbactam EV seguida de amoxicilina/clavulánico oral). La cirugía o el drenaje percutáneo (A, C) solo se reservan para fracaso terapéutico médico tras 7 a 10 días, hemoptisis masiva o sospecha de lesión maligna.

PREGUNTA 33 **Respuesta: B**

1.05.1.001, 1.05.1.008 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Absceso Pulmonar y Supuraciones Pleuropulmonares

Las cavidades de origen neoplásico (frecuentemente carcinoma epidermoide o escamoso central necrosado) se diferencian de los abscesos benignos por tener paredes típicamente muy engrosadas (> 15 mm), contornos internos irregulares, festoneados o con proyecciones nodulares. El esputo fétido (A) y la sepsis dental (E) son propios del absceso anaerobio benigno.

PREGUNTA 34 **Respuesta: B**

1.05.1.008 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Absceso Pulmonar y Supuraciones Pleuropulmonares

El absceso pulmonar bacteriano no complicado tiene un éxito terapéutico mayor al 85-90% exclusivamente con tratamiento médico antimicrobiano prolongado (4 a 6 semanas con cobertura anaerobia como ampicilina/sulbactam EV seguida de amoxicilina/clavulánico oral). La cirugía o el drenaje percutáneo (A, C) solo se reservan para fracaso terapéutico médico tras 7 a 10 días, hemoptisis masiva o sospecha de lesión maligna.

PREGUNTA 35 **Respuesta: C**

1.05.1.036 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento

Es un paciente contacto estrecho y sintomático, que, además, ya tiene una prueba positiva para tuberculosis (el quatiferón). Por tanto, aunque tenga las baciloscopías negativas se debe iniciar el tratamiento y no es necesario pedir la PCR.

PREGUNTA 36 **Respuesta: C**

1.05.1.037 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento

El etambutol es el responsable clásico de la neuritis óptica retrobulbar, un efecto adverso dosis-dependiente que se manifiesta por disminución de la agudeza visual central, escotomas centrales y la característica pérdida precoz de la discriminación de los colores rojo y verde (discromatopsia). Ante la aparición de estos síntomas se debe suspender inmediatamente el etambutol y evaluar por oftalmología.

BLOQUE 3 PATOLOGÍA PLEURAL Y URGENCIAS TORÁCICAS · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 37 **Respuesta: A** **Traumatismo torácico simple** 1.05.2.014 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Traumatismo torácico simple" como urgencia clínica (1.05.2.014), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 38 **Respuesta: D**

1.05.1.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Derrame Pleural: Diagnóstico Diferencial y Criterios de Light

Tiene un líquido pleural sugerente de cáncer (exudado: cumple todos los criterios de light; mononuclear; con ADA menor a 30). Dado que la radiografía no muestra un tumor pulmonar, se debe proceder a las biopsias pleurales, las que se hacen por videotoracoscopía y, si no está disponible, de manera percutánea.

PREGUNTA 39 **Respuesta: C**

1.05.1.010 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Derrame Pleural: Diagnóstico Diferencial y Criterios de Light

Aplicando los Criterios de Light: Relación Proteínas LP/S = 2.1 / 6.4 = 0.32 (es ≤ 0.5); Relación LDH LP/S = 90 / 210 = 0.42 (es ≤ 0.6); y LDH pleural 90 U/L es inferior a los 2/3 del límite superior sérico (2/3 de 200 = 133 U/L). Al no cumplir ninguno de los tres criterios, se clasifica de forma concluyente como TRASUDADO. La causa más habitual de trasudado en el adulto mayor es la insuficiencia cardíaca congestiva o la hipertensión portal cirrótica.

PREGUNTA 40 **Respuesta: B**

1.05.1.010 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Derrame Pleural: Diagnóstico Diferencial y Criterios de Light

El síndrome de derrame pleural interpone una capa líquida entre el pulmón y la pared torácica, lo que bloquea la transmisión del sonido y altera la resonancia. Por ello genera la tríada semiológica patognomónica: (1) Abolición o disminución marcada de las vibraciones vocales táctiles, (2) Matidez hídrica franca a la percusión (sin resonancia aérea), y (3) Abolición o disminución extrema del murmullo pulmonar a la auscultación.

PREGUNTA 41 **Respuesta: A**

Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural

1.05.1.011 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Neumonía con Derrame Paraneumónico: El manejo de una neumonía con derrame paraneumónico complicado (por el lactato pleural > 5 mmol/L) incluye drenaje completo del derrame pleural (medida más importante), tubo pleural y metronidazol para cubrir bacterias anaerobias.

PREGUNTA 42 **Respuesta: B**

Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural

1.05.1.011, 1.05.1.012 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El líquido pleural cumple criterios bioquímicos categóricos de derrame paraneumónico complicado: pH < 7.20 (7.14), glucosa < 40 mg/dL (32 mg/dL) y LDH > 1.000 U/L (2.200 U/L). A pesar de que la tinción de Gram sea inicialmente negativa, la acidosis láctica y el consumo extremo de glucosa certifican actividad bacteriana e inflamatoria intensa en el espacio pleural. La indicación indiscutible es el drenaje pleural inmediato mediante la instalación de un tubo de tórax (pleurostomía cerrada) para evitar la tabicación y el empiema multiloculado.

PREGUNTA 43 **Respuesta: B**

Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural

1.05.1.011, 1.05.1.012 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El pH del líquido pleural medido en condiciones anaeróbicas es el parámetro bioquímico más sensible y con mayor respaldo en la literatura médica internacional (guías BTS y ACCP) para definir un derrame paraneumónico complicado y la necesidad de drenaje con tubo de tórax. Un pH < 7.20 indica un ambiente intensamente ácido secundario al metabolismo anaerobio bacteriano y leucocitario, lo que predice con más de 95% de precisión que el derrame no se resolverá con antibióticos solos.

PREGUNTA 44 **Respuesta: B**

Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural

1.05.1.011, 1.05.1.012 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

En el empiema pleural, especialmente en pacientes con factores de riesgo como alcoholismo crónico, trastornos deglutorios o patología periodontal, existe una alta participación de bacterias anaerobias orales (Fusobacterium, Peptostreptococcus, Bacteroides) asociadas a estreptococos y bacilos gramnegativos. La terapia antibiótica empírica de elección según las guías clínicas nacionales e internacionales es Ampicilina/Sulbactam 1.5 a 3 g cada 6 horas EV, o la combinación de Ceftriaxona 2 g EV al día más Metronidazol 500 mg cada 8 horas EV para asegurar cobertura anaerobia sólida.

PREGUNTA 45 **Respuesta: B**

Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural

1.05.1.011, 1.05.1.012 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Cuando un empiema o derrame paraneumónico complicado se encuentra en fase fibrinopurulenta avanzada con múltiples tabicaciones y loculaciones que impiden el drenaje efectivo por el tubo de pleurostomía, la conducta recomendada es la terapia intrapleural combinada con fibrinolíticos (Alteplasa/t-PA 10 mg + Dornasa alfa/DNAsa 5 mg dos veces al día por 3 días según el protocolo MIST-2) o bien la intervención quirúrgica precoz mediante Cirugía Toracoscópica Videoasistida (VATS) para debridamiento y lisis de adherencias bajo visión directa.

PREGUNTA 46 **Respuesta: C**

Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural

1.05.1.012 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Por ser una neumonía, con derrame (paraneumónico simple en este caso), se debe manejar hospitalizada (ATS III), por lo que el ATB de elección es la ceftriaxona.

PREGUNTA 47 **Respuesta: C**

Neumotórax Espontáneo Primario y Secundario

1.05.1.031 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Clínica muy sugerente de neumotórax

PREGUNTA 48 **Respuesta: C**

1.05.1.031 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Neumotórax Espontáneo Primario y Secundario

Se trata de un neumotórax espontáneo primario pequeño (< 2 cm de separación interpleural) en un paciente completamente estable y asintomático. Las guías clínicas internacionales recomiendan manejo conservador mediante reposo, administración de oxígeno (que aumenta el gradiente para la reabsorción del aire del espacio pleural) y observación médica durante 4 a 6 horas. La punción con bránula (D) es exclusiva del neumotórax a tensión con shock, y el tubo (A) se reserva para neumotórax grandes o sintomáticos.

PREGUNTA 49 **Respuesta: B**

1.05.1.031 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Neumotórax Espontáneo Primario y Secundario

Tras un primer episodio de neumotórax espontáneo primario, la tasa de recurrencia es del 30%, pero tras un segundo episodio homolateral el riesgo de un tercer evento supera el 50–60%. Por ello, la indicación quirúrgica clásica y de consenso para realizar resección de blebs (bullectomía) asociada a pleurodesis (química o abrasión mecánica) por videotoracoscopía (VATS) es la presencia de un segundo episodio en el mismo lado o la persistencia de fuga aérea por más de 48-72 horas.

PREGUNTA 50 **Respuesta: A**

1.05.1.032 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático

Es una pregunta difícil, ya que no se ve bien la radiografía (en el Eunacom original era muy difícil verlo), pero tiene clínica de un neumotórax espontáneo. El manejo es con tubo pleural, pero en los casos en que no hay colapso pulmonar, es posible observarlo, darle analgesia y controlarlo con nuevas radiografías. En este caso, que lleva 2 días sin agravarse, lo más correcto es controlar con radiografía en 24 horas.

PREGUNTA 51 **Respuesta: B**

1.05.1.032, 1.05.2.011, 1.05.2.013 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Inicial GES

Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático

El cuadro clínico corresponde sin duda a un Neumotórax a Tensión derecho con inestabilidad hemodinámica extrema por colapso del retorno venoso (shock obstructivo). Es un error médico grave retrasar el tratamiento esperando exámenes radiológicos (A) o intubar con presión positiva (C), ya que la ventilación mecánica aumentará la presión intratorácica y provocará paro cardíaco inmediato. La conducta salvadora inmediata es la descompresión con aguja gruesa para aliviar la tensión intrapleural, seguida de tubo de drenaje pleural.

PREGUNTA 52 **Respuesta: B**

1.05.2.011 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Inicial GES

Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático

El cuadro clínico corresponde sin duda a un Neumotórax a Tensión derecho con inestabilidad hemodinámica extrema por colapso del retorno venoso (shock obstructivo). Es un error médico grave retrasar el tratamiento esperando exámenes radiológicos (A) o intubar con presión positiva (C), ya que la ventilación mecánica aumentará la presión intratorácica y provocará paro cardíaco inmediato. La conducta salvadora inmediata es la descompresión con aguja gruesa para aliviar la tensión intrapleural, seguida de tubo de drenaje pleural.

PREGUNTA 53 **Respuesta: B**

1.05.2.013 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Inicial GES

Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático

El cuadro clínico corresponde sin duda a un Neumotórax a Tensión derecho con inestabilidad hemodinámica extrema por colapso del retorno venoso (shock obstructivo). Es un error médico grave retrasar el tratamiento esperando exámenes radiológicos (A) o intubar con presión positiva (C), ya que la ventilación mecánica aumentará la presión intratorácica y provocará paro cardíaco inmediato. La conducta salvadora inmediata es la descompresión con aguja gruesa para aliviar la tensión intrapleural, seguida de tubo de drenaje pleural.

PREGUNTA 54 **Respuesta: B**

Derrame Pleural Neoplásico y Pleuritis Tuberculosa

1.05.1.013 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El cuadro clínico y el líquido pleural (exudado mononuclear con ADA > 40 U/L) son altamente sugerentes de pleuritis tuberculosa. Dado que el bacilo de Koch se encuentra en baja cantidad libre en el líquido (baciloscopía líquida positiva en menos del 10%), el método diagnóstico de mayor rendimiento (> 80-90%) es la biopsia pleural con aguja (Cope o Abrams), que permite visualizar los granulomas con necrosis caseosa y cultivar el tejido.

BLOQUE 4 ONCOLOGÍA PULMONAR, INTERSTICIO Y VASCULAR · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 55 **Respuesta: A** **Síndromes mediastínicos**

1.05.1.034 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. Para la situación clínica "Síndromes mediastínicos" (1.05.1.034), el estándar del Perfil V3 exige Diagnóstico Sospecha, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. El médico general en atención primaria debe aplicar la sospecha o confirmación clínica mediante el estudio normado por MINSAL, iniciar las medidas terapéuticas basales y derivar a nivel secundario si el caso requiere seguimiento especializado. Las alternativas B, C, D y E omiten el estándar técnico o aplican medidas desproporcionadas.

PREGUNTA 56 **Respuesta: B**

Nódulo Pulmonar Solitario (NPS): Evaluación y Algoritmo Fleischner

1.05.1.008, 1.05.5.005 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

En todo paciente con un nódulo pulmonar solitario recién detectado, el primer paso clínico y con mayor costo-efectividad antes de indicar procedimientos invasivos es buscar y revisar las radiografías o tomografías previas. Si la lesión ya estaba presente y con idéntico tamaño y características hace 2 o 3 años, se confirma la estabilidad y benignidad de la lesión, evitando biopsias, cirugías innecesarias o radiación adicional.

PREGUNTA 57 **Respuesta: C**

Nódulo Pulmonar Solitario (NPS): Evaluación y Algoritmo Fleischner

1.05.1.008, 1.05.5.005 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El hamartoma es la neoplasia benigna más común del pulmón. Su hallazgo clásico en la tomografía computarizada de alta resolución es la presencia de una lesión bien delimitada que contiene calcificaciones internas gruesas dispuestas en "palomitas de maíz" (popcorn) y áreas focales hipodensas de tejido adiposo (densidad entre -40 y -120 UH). Esta combinación confirma categóricamente el origen benigno sin requerir resección.

PREGUNTA 58 **Respuesta: E**

Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial

1.05.1.007 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Cáncer de Pulmón: El cuadro clínico y la radiografía sugerían un cáncer de pulmón, pero ninguna de las opciones del Eunacom real tenían dicha respuesta. Así es el Eunacom y no se puede reclamar. Para efectos de subirlo a la plataforma, incluimos la opción.

PREGUNTA 59 **Respuesta: A**

Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial

1.05.1.007, 1.05.1.025, 1.05.1.038 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El paciente presenta una masa central perihiliar asociada a hiponatremia hipotónica euvolémica con orina inapropiadamente concentrada (Osm urinaria > 100 y Na urinario > 30), lo que certifica un Síndrome de Secreción Inadecuada de Hormona Antidiurética (SIADH). El SIADH es el síndrome paraneoplásico endocrino más característico del Carcinoma Pulmonar Microcítico (de células pequeñas u oat cell), el cual produce ADH ectópica en un 10–15% de los pacientes.

PREGUNTA 60 **Respuesta: B**

Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial

1.05.1.007, 1.05.1.025, 1.05.1.038 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El Tumor de Pancoast (tumor del surco pulmonar superior) se ubica en el vértice apical y comprime estructuras vecinas: el plexo braquial inferior (raíces C8, T1 y T2) generando dolor urente irradiado al borde cubital del brazo, y la cadena simpática cervical/ganglio estrellado, provocando el Síndrome de Claude-Bernard-Horner ipsilateral caracterizado por la tríada clásica de ptosis palpebral, miosis y anhidrosis facial.

PREGUNTA 61 **Respuesta: A**

Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial

1.05.1.025 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El paciente presenta una masa central perihiliar asociada a hiponatremia hipotónica euvolémica con orina inapropiadamente concentrada (Osm urinaria > 100 y Na urinario > 30), lo que certifica un Síndrome de Secreción Inadecuada de Hormona Antidiurética (SIADH). El SIADH es el síndrome paraneoplásico endocrino más característico del Carcinoma Pulmonar Microcítico (de células pequeñas u oat cell), el cual produce ADH ectópica en un 10–15% de los pacientes.

PREGUNTA 62 **Respuesta: A**

Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial

1.05.1.038 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

Tiene un nódulo pulmonar solitario parahiliar derecho. Lo primero es el TAC. Luego será la Bx transbronquial, mediante broncoscopía. Si hubiese tenido radiografías previas, lo primero habría sido revisarlas, antes del TAC.

PREGUNTA 63 **Respuesta: C**

Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas (EPID) y Fibrosis Pulmonar Idiopática

1.05.1.018 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es una fibrosis pulmonar.

PREGUNTA 64 **Respuesta: B**

Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas (EPID) y Fibrosis Pulmonar Idiopática

1.05.1.018, 1.05.1.026 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El paciente reúne la clínica prototípica (varón > 60 años, disnea progresiva, crépitos en velcro, acropaquia) y el patrón tomográfico categórico de Neumonía Intersticial Usual (NIU con panalización subpleural bibasal y bronquiectasias por tracción sin hallazgos alternativos), lo que establece el diagnóstico certero de Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI). En la FPI los corticoides están formalmente contraindicados por aumentar la mortalidad; el tratamiento indicado son los fármacos antifibróticos como el nintedanib o la pirfenidona.

PREGUNTA 65 **Respuesta: B**

Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas (EPID) y Fibrosis Pulmonar Idiopática

1.05.1.018, 1.05.1.026 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La amiodarona es un antiarrítmico de clase III que se acumula masivamente en el parénquima pulmonar y tejido adiposo, causando toxicidad pulmonar en el 5–10% de los usuarios crónicos. Se manifiesta clínicamente por tos seca, disnea de esfuerzo progresiva e infiltrados intersticiales o alveolares densos bilaterales en la TACAR (debido al alto contenido de yodo del fármaco). El enalapril produce tos seca pero no enfermedad intersticial.

PREGUNTA 66 **Respuesta: B**

Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas (EPID) y Fibrosis Pulmonar Idiopática

1.05.1.026 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Antecedente de minería orienta a neumoconiosis. La Rx era distinta a la que ahí se muestra.

PREGUNTA 67 **Respuesta: C**

Tromboembolismo Pulmonar (TEP) Agudo: Wells, Ginebra y Estratificación

1.05.1.015 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El exudado hemorrágico orienta a TEP. También el Sd. nefrótico, que se complica con TEP. También el inicio súbito.

PREGUNTA 68 **Respuesta: B**

Tromboembolismo Pulmonar (TEP) Agudo: Wells, Ginebra y Estratificación

1.05.1.015, 1.05.2.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El paciente presenta un Tromboembolismo Pulmonar de Alto Riesgo (TEP Masivo), definido por la presencia de hipotensión persistente (PAS < 90 mmHg / shock) secundaria a falla aguda del ventrículo derecho por obstrucción masiva del lecho vascular pulmonar. En ausencia de contraindicaciones absolutas mayores (hemorragia activa intracraneal), la terapia farmacológica salvadora de primera línea es la reperfusión inmediata mediante Trombolisis sistémica (Alteplasa 100 mg EV en 2 h). La sobrecarga agresiva de volumen (D) agrava la falla ventricular derecha.

PREGUNTA 69 **Respuesta: D**

Tromboembolismo Pulmonar (TEP) Agudo: Wells, Ginebra y Estratificación

1.05.2.005 Dx: Sospecha · Tx: Completo · Seg: Derivar GES

Es un TEP masivo (compromiso hemodinámico), por lo que se estudia con ecocardiograma (para evaluar la disfunción del ventrículo derecho), y no con el angioTAC (de elección en el TEP no masivo).

PREGUNTA 70 **Respuesta: B**

Hemoptisis y Bronquiectasias

1.05.1.004 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Tiene un cuadro compaGble con bronquiectasias. Se debe revisar el resumen de semiología respiratoria. El diagnóstico se confirma con TAC de tórax de alta resolución.

PREGUNTA 71 **Respuesta: B**

Hemoptisis y Bronquiectasias

1.05.1.019 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

En una hemoptisis amenazante la causa principal de muerte es la asfixia por inundación de sangre en las zonas alveolares ventiladas. La medida física obligatoria de rescate es colocar al paciente en decúbito lateral hacia el lado donde se ubica la lesión sangrante (en este caso el hemitórax derecho). De esta forma, la gravedad mantiene la sangre acumulada en el pulmón afecto y previene que el sangrado atraviese la carina traqueal e inunde el pulmón contralateral sano, preservando el intercambio gaseoso.

PREGUNTA 72 **Respuesta: B**

Hemoptisis y Bronquiectasias

1.05.2.007 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

En una hemoptisis amenazante la causa principal de muerte es la asfixia por inundación de sangre en las zonas alveolares ventiladas. La medida física obligatoria de rescate es colocar al paciente en decúbito lateral hacia el lado donde se ubica la lesión sangrante (en este caso el hemitórax derecho). De esta forma, la gravedad mantiene la sangre acumulada en el pulmón afecto y previene que el sangrado atraviese la carina traqueal e inunde el pulmón contralateral sano, preservando el intercambio gaseoso.

BLOQUE 5 CUIDADOS CRÍTICOS, VENTILACIÓN Y MEDICINA DEL SUEÑO · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 73 **Respuesta: A** **Asfixia por inmersión** 1.05.2.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Asfixia por inmersión" como urgencia clínica (1.05.2.001), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 74 **Respuesta: A** **Paro cardiorespiratorio** 1.05.2.012 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Paro cardiorespiratorio" como urgencia clínica (1.05.2.012), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Completo y Seguimiento Completo. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 75 **Respuesta: C**

Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica)

1.05.1.023 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El paciente presenta una acidosis respiratoria aguda descompensada (pH 7.24, PaCO2 65 mmHg) con hipoxemia moderada (PaO2 55 mmHg). El dato decisivo es el Gradiente Alvéolo-Arterial de Oxígeno [P(A-a)O2], el cual es rigurosamente normal (12 mmHg). Cuando la hipoxemia se acompaña de hipercapnia con gradiente A-a normal, el único mecanismo fisiopatológico posible es la hipoventilación alveolar pura secundaria a la depresión central del estímulo ventilatorio por fármacos.

PREGUNTA 76 **Respuesta: C**

Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica)

1.05.1.023, 1.05.2.008, 1.05.2.009 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El paciente presenta una acidosis respiratoria aguda descompensada (pH 7.24, PaCO2 65 mmHg) con hipoxemia moderada (PaO2 55 mmHg). El dato decisivo es el Gradiente Alvéolo-Arterial de Oxígeno [P(A-a)O2], el cual es rigurosamente normal (12 mmHg). Cuando la hipoxemia se acompaña de hipercapnia con gradiente A-a normal, el único mecanismo fisiopatológico posible es la hipoventilación alveolar pura secundaria a la depresión central del estímulo ventilatorio por fármacos.

PREGUNTA 77 **Respuesta: B**

Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica)

1.05.1.023, 1.05.2.008, 1.05.2.009 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El efecto Shunt intrapulmonar verdadero se produce cuando la sangre desoxigenada perfunde alvéolos completamente colapsados o inundados de líquido o pus (como ocurre en el SDRA grave, edema pulmonar masivo o atelectasia lobar total). Como el gas inspirado no entra en contacto con la sangre capilar de esas unidades no ventiladas, el aporte de O2 al 100% no logra oxigenar dicha fracción sanguínea, resultando en hipoxemia refractaria al oxígeno.

PREGUNTA 78 **Respuesta: B**

Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica)

1.05.1.023, 1.05.2.008, 1.05.2.009 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

La paciente presenta una IRA Tipo 1 (PaO2 52 mmHg con PaCO2 32 mmHg). La ecuación del gas alveolar arroja PAO2 = 150 - (32 / 0.8) = 110 mmHg. Al restar la PaO2 arterial (110 - 52), el gradiente alvéolo-arterial es de 58 mmHg (valor normal para su edad < 20 mmHg). Un gradiente A-a marcadamente elevado descarta categóricamente una causa extrapulmonar (como hipoventilación o altitud) y confirma la existencia de un daño estructural intrínseco del parénquima pulmonar (como neumonía comunitaria) o de la microvasculatura pulmonar (TEP).

PREGUNTA 79 **Respuesta: B**

Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica)

1.05.1.023, 1.05.2.008, 1.05.2.009 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El paciente presenta una exacerbación aguda de EPOC complicada con acidosis respiratoria hipercápnica descompensada (pH 7.27 y PaCO2 66 mmHg). En este escenario, la Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI en modalidad BiPAP) es la terapia de soporte ventilatorio de primera línea con recomendación grado 1A: disminuye el trabajo respiratorio, favorece el lavado de CO2, previene la intubación endotraqueal en más del 60% de los pacientes y reduce drásticamente la mortalidad hospitalaria. La intubación orotraqueal se reserva si la VMNI fracasa, si el pH es < 7.20-7.25 refractario o si hay coma profundo.

PREGUNTA 80 **Respuesta: E**

Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica)

1.05.2.008 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

Hay evidencia de baja calidad y reciente, muy discutida, que dicen que la ventilación mecánica invasiva tendría mejores resultados en mortalidad y en tiempo de hospitalización, que la oxigenoterapia por mascarilla. Pregunta muy discutible, porque en la vida real, se evaluará primero la respuesta al oxígeno y se irá viendo cuánto necesita para saturar adecuadamente.

PREGUNTA 81 **Respuesta: C**

Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica)

1.05.2.009 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El paciente presenta una acidosis respiratoria aguda descompensada (pH 7.24, PaCO2 65 mmHg) con hipoxemia moderada (PaO2 55 mmHg). El dato decisivo es el Gradiente Alvéolo-Arterial de Oxígeno [P(A-a)O2], el cual es rigurosamente normal (12 mmHg). Cuando la hipoxemia se acompaña de hipercapnia con gradiente A-a normal, el único mecanismo fisiopatológico posible es la hipoventilación alveolar pura secundaria a la depresión central del estímulo ventilatorio por fármacos.

PREGUNTA 82 **Respuesta: B**

Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA): Criterios de Berlín

1.05.1.014 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

El paciente cumple los criterios de Berlín para SDRA: factor de riesgo conocido (sepsis abdominal), tiempo < 7 días, opacidades bilaterales difusas y exclusión de edema cardiogénico. Al tener una relación PaFiO2 de 90 mmHg (con PEEP ≥ 5), se clasifica como SDRA Severo (PaFi ≤ 100). En esta categoría grave, la estrategia con evidencia de máxima categoría para reducir la mortalidad es la ventilación protectora (volumen corriente bajo de 6 mL/kg de peso predicho) y la colocación precoz en decúbito prono durante al menos 16 horas diarias (ensayo PROSEVA).

PREGUNTA 83 **Respuesta: B**

Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA): Criterios de Berlín

1.05.1.014 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

La Presión Meseta o Plateau (medida realizando una pausa inspiratoria al final de la insuflación) refleja la presión estática que experimentan directamente los alvéolos. La evidencia internacional de ventilación protectora (ARDS Network) ha demostrado que mantener la Presión Plateau en un límite ≤ 30 cmH2O previene la sobredistensión alveolar cíclica y el barotrauma, siendo el parámetro de seguridad alveolar por excelencia. La presión peak (A) incluye la resistencia de la vía aérea y puede elevarse sin necesariamente sobredistender el alvéolo.

PREGUNTA 84 **Respuesta: B**

Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS)

1.05.1.033 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tiene un síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño severa (>30 eventos por hora; moderada es entre 20 y 30; leve es <20), por lo que requiere C- PAP (se indica en la severa y en la que no responde al tratamiento médico de baja de peso y cambios de posición al dormir). La cirugía podría servir, pero requiere de obstrucción anatómica y además, dada la severidad, el C-PAP igual es de elección.

PREGUNTA 85 **Respuesta: B**

Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS)

1.05.1.033 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

El cuadro clínico describe la presentación prototípica de un Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS): paciente con sobrepeso u obesidad, ronquidos intensos, apneas presenciadas por terceros y marcada hipersomnolencia diurna con puntaje de Epworth anormal (> 10). El examen estándar de referencia para confirmar de manera objetiva el diagnóstico, cuantificar el Índice de Apnea-Hipoapnea (IAH) y graduar la desaturación de oxígeno es la Polisomnografía nocturna.

PREGUNTA 86 **Respuesta: B**

Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS)

1.05.1.033 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

En el SAHOS moderado a severo (IAH ≥ 15, y particularmente con IAH ≥ 30), el tratamiento de primera línea no quirúrgico de máxima eficacia es el CPAP nasal nocturno continuo. El CPAP actúa generando una presión positiva hidroneumática constante que mantiene permeable la vía aérea faríngea, aboliendo los ronquidos, las apneas y los microdespertares, normalizando la presión arterial y eliminando la somnolencia diurna. Las benzodiacepinas (E) agravan el colapso.

PREGUNTA 87 **Respuesta: B**

1.05.1.024 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Inicial GES

Intoxicación por Monóxido de Carbono e Inhalación de Humo

Los oxímetros de pulso habituales miden la absorción de luz a solo dos longitudes de onda (660 y 940 nm), incapaces de diferenciar la oxihemoglobina de la carboxihemoglobina, interpretando falsamente el compuesto tóxico como hemoglobina saturada de oxígeno (99-100%). Frente a una sospecha epidemiológica clara de exposición a brasero con cefalea, es un error médico fatal confiar en el saturómetro. Se debe iniciar de inmediato oxígeno al 100% con mascarilla de reservorio y confirmar con co-oximetría.

PREGUNTA 88 **Respuesta: B**

1.05.1.024, 1.05.2.010 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Inicial GES

Intoxicación por Monóxido de Carbono e Inhalación de Humo

Los oxímetros de pulso habituales miden la absorción de luz a solo dos longitudes de onda (660 y 940 nm), incapaces de diferenciar la oxihemoglobina de la carboxihemoglobina, interpretando falsamente el compuesto tóxico como hemoglobina saturada de oxígeno (99-100%). Frente a una sospecha epidemiológica clara de exposición a brasero con cefalea, es un error médico fatal confiar en el saturómetro. Se debe iniciar de inmediato oxígeno al 100% con mascarilla de reservorio y confirmar con co-oximetría.

PREGUNTA 89 **Respuesta: C**

1.05.1.024, 1.05.2.010 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Inicial GES

Intoxicación por Monóxido de Carbono e Inhalación de Humo

Las indicaciones estrictas y de consenso para el uso de Oxigenoterapia Hiperbárica (cámara hiperbárica) en intoxicación por monóxido de carbono son: (1) Antecedente de síncope, pérdida de conciencia, coma o convulsiones; (2) Presencia de signos neurológicos focales persistentes; (3) Nivel de Carboxihemoglobina > 25% (o > 15% en mujeres embarazadas); y (4) Evidencia de isquemia miocárdica aguda en el electrocardiograma o acidosis metabólica severa.

PREGUNTA 90 **Respuesta: C**

1.05.2.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Intoxicación por Monóxido de Carbono e Inhalación de Humo

La sospecha es una intoxicación por monóxido de carbono. La saturación de oxígeno es falsamente normal en la oximetría de pulso. Los gases arteriales suelen ser normales, ya que la PaO2 no se altera, sino que el monóxido de carbono desplaza al oxígeno en la hemoglobina. Tampoco Genen cianosis (“muertos rosados”). El examen diagnóstico de elección es la medición de carboxihemoglobina. El tratamiento de elección es el oxígeno al 100%. La terapia hiperbárica, además, está indicada si la carboxihemoglobina es mayor a 25% (20% en embarazo) o si hay compromiso de conciencia.
